

*Que
sais-je?*

LA DÉPRESSION

HENRI LÔO ET PIERRE LÔO



PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
Kahle/Austin Foundation

QUE SAIS-JE ?

La dépression

HENRI LÔO

PIERRE LÔO

Deuxième édition mise à jour

10^e mille



« Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé »

En remerciant pour leur aide les personnalités
suivantes : J. Bonnel, D. Brillaud, V. Caillard,
D. Donnet, E. Hantouche, F. Rouillon, H. Troisier.

ISBN 2 13 0446035 5

Dépôt légal — 1^{re} édition : 1991

2^e édition mise à jour : 1993, janvier

© Presses Universitaires de France, 1991

108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

AVANT-PROPOS

« Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé ! » Aveu désespéré, plainte, un appel peut-être ?... C'est la dépression.

Souvent méconnue, parfois dramatisée et jugée incurable, elle est aujourd'hui sujet de discussions. La clinique traditionnelle, minutieuse accumulation d'expérience et de savoir, riche formation alluvionnaire de tant de générations, en a établi la nature, précisé les aspects et la gravité différents.

Un mouvement moderniste qui confond parfois nouveauté et progrès en fait une analyse originale avec des techniques nouvelles.

Comme en politique, on trouve les conservateurs et les novateurs. Accueil réticent, parfois ironique des premiers pour ce *fast-food* psychiatrique, pour l'enthousiasme dévot des pèlerins d'Amérique, surtout à l'égard d'une certaine robotisation qui esquivé un laborieux et difficile artisanat.

Les novateurs, délaissant le sinueux parcours des anciens cliniciens, déploient une stratégie expéditive : critères, classifications, échelles d'évaluation, échelles d'auto-appréciation, questionnaires, tests vont vite et droit au but. Recherche de rapidité (pour apprécier dans un bref délai l'action des médicaments), d'efficacité (pour classer et même quantifier la perturbation psychique) ; une attitude, pas nécessairement négative, car à travers l'aspect parfois naïf des items la subjectivité des malades peut s'exprimer.

Cet esprit nouveau, animé par un souci de rende-

ment, s'étend, au risque d'en assécher l'humanisme, à toute la médecine et à diverses disciplines.

Mais le présent, le futur réalisent les virtualités du passé où ils trouvent leurs racines. Le hasard peut faire surgir des ouvertures nouvelles.

L'information ne doit sous-estimer aucun apport culturel ni se rétrécir dans l'alternative manichéenne entre « un passé exclu des mémoires et un avenir exclu des imaginations » (A. Frossard).

Les eaux mêlées (clinique traditionnelle, vieux fleuve étincelant ; courants nouveaux, impétueux) doivent confluer dans un œcuménisme psychiatrique pour élargir la connaissance, l'enrichir de toutes les valeurs et, dans le naufrage de la dépression, répondre de façon oblatrice, avec de plus efficaces moyens, à l'angoisse de l'homme.

« Des semences d'idées pour féconder le monde » (M. Yourcenar).

Réflexions des auteurs sur la première édition

Après le flux et le reflux, les rajouts et les ratures, flottent encore quelques épaves !

Oublis, omissions volontaires, sélections hasardeuses, choix contestables entre le non-dit et le proféré dans les contraignantes limites de l'édition.

D'abord la symptomatologie conventionnelle dont la diversité des formes cliniques justifierait une plus large exploration, de plus précises nuances, parfois des contestations. Comme la sexualité du déprimé jugée par les classiques, « éteinte », « amortie », dans un raccourci simplificateur, bien souvent erroné.

On pourrait aussi évoquer le « vécu » mélancolique. Analysé rétrospectivement il révèle des étapes différentes de dissolution de la conscience, selon les théories de Jackson reprises par Ey. Parfois le souvenir du

thème délirant reste précis chez le sujet et le déconcerte par sa distance avec le réel (idées de ruine par exemple). Chez d'autres, il persiste une vague mémoire, d'obscur images de menaces, de sévices ou de jugements. Mais certains ont tout oublié. Ils contestent, souvent indignés quand on les rapporte, leurs propos auto-accusateurs.

Nous avons fait une concession à la distinction conventionnelle entre dépression névrotique, psychotique et réactionnelle. Mais en réalité une dépression est de nature névrotique ou de nature mélancolique. Elle peut être dans sa cause réactionnelle à un événement, mais elle s'exprime dans l'une ou l'autre de ces deux formes.

Quelques corrections ; surtout, dans un souci de clarté, nous avons apporté des modifications au chapitre des causes de la dépression.

Beaucoup de références et de citations peut-être ? Mais pourquoi ignorer, des autres, les idées et ne pas les laisser exprimer les nôtres quand ils le disent mieux que nous ? Nous avons accueilli avec reconnaissance d'utiles et pertinentes critiques... et si « quelques encens embaument nos autels », nous savons que l'amitié et la bienveillance infléchissent le jugement.

INTRODUCTION

« Comme de longs échos qui de loin se confondent », les complaints, élégiaques ou désespérées, expriment à travers le temps, et sous toutes les latitudes, la fragilité et l'angoisse de l'homme. L'homme « faible et qui souffre » subit les oscillations de son équilibre psychique et parfois ses défaillances : du découragement au pessimisme, du désespoir au naufrage du suicide.

C'est la dépression. Un ténébreux état d'âme, un « vécu » de tonalité triste dont l'ampleur et l'intensité varient comme la durée. Mais la frontière est souvent incertaine entre le normal et le pathologique. La dépression, terme relativement nouveau, n'est pas, comme on le croit, une maladie spécifique des temps modernes, induite par les difficultés existentielles ou les exigences d'une société contraignante.

Elle se rencontre dans tous les milieux sociaux et dans les diverses cultures. Elle peut toucher le fermier des haciendas sud-américaines, le paysan du Haut-Atlas maghrébin, le financier cossu, la mère de famille d'un foyer heureux, le retraité désœuvré, la vedette célèbre et

*« la garde qui veille aux barrières du Louvre,
n'en défend pas les rois » (Malherbe).*

Certaines dépressions ne relèvent pas de la psychose mais de la névrose. La dépression névrotique est très différente de la dépression mélancolique psychotique, dans son expression, sa nature, ses virtualités.

Rappel historique

La dépression est connue depuis l'Antiquité.

Hippocrate en rapporte des descriptions cliniques. Il attribue l'affection à la « bile noire ».

Cette conception lointaine survit-elle dans l'expression populaire : « se faire de la bile » ?

La traduction littérale du grec « bile noire » donnera le terme « mélancolie ». Il désigne, aujourd'hui, certaines formes particulières de dépression.

La théorie humorale hippocratique persiste encore, après une éclipse au Moyen Age, quand dépression et maladies mentales étaient suspectes de possession démoniaque, dans l'ambiance passionnelle de l'Inquisition.

La notion de mélancolie traverse les siècles ; elle se module en significations imprécises et fluctuantes qui ne renvoient pas toujours à l'authentique mélancolie, trouble profond de l'humeur caractérisé par une tristesse pathologique.

Au ^{xix}^e siècle, les auteurs isolent dans le groupe des délires (dénommés monomanies), le « délire partiel triste » appelé lypémanie par Esquirol.

Puis apparaissent les notions de folie circulaire (Falret) et de folie à double forme (Baillarger) pour désigner les dépressions récidivantes alternant avec des accès d'agitation euphorique dits excitation maniaque ou manie. Ces auteurs avaient en effet repéré l'alternance de deux tableaux cliniques différents, d'apparence opposée, se succédant dans le temps avec ou sans intervalle lucide :

- l'accès dépressif mélancolique, d'une part ;
- l'accès d'excitation euphorique ou manie, d'autre part.

Une même maladie, caractérisée par des troubles de l'humeur avec deux versants opposés : tristesse et apathie d'un côté, joie et exaltation active de l'autre. Les

troubles de l'humeur alternés surviennent de façon cyclique et la maladie sera baptisée psychose cyclique, psychose intermittente, psychose à double forme et enfin, psychose maniaco-dépressive par Kraepelin, terme actuel.

Mais les états dépressifs de la psychose maniaco-dépressive ne résument pas les dépressions, ils en constituent seulement un sous-groupe.

Concept de dépression

Employé incidemment par Baillarger au ^{xix}^e siècle, le terme dépression s'impose définitivement lorsque Kraepelin l'introduit systématiquement pour décrire les périodes de tristesse et d'abattement qui alternent avec les phases d'excitation et d'euphorie de la psychose maniaco-dépressive. C'est la dépression mélancolique.

Par la suite, le mot dépression déborde ce cadre pathologique pour désigner tous les épisodes de tristesse, de baisse du tonus psychique altérant le comportement, les capacités et le vécu du sujet.

Le sentiment de tristesse n'est pas la dépression, mais la dépression comporte inévitablement la tristesse dont l'intensité peut retentir sur la vie quotidienne, l'activité, l'appréciation de soi, le jugement et les fonctions élémentaires comme le sommeil et l'appétit.

Il est difficile de préciser la frontière entre la tristesse légitime et la tristesse pathologique. La différence s'établit en termes quantitatifs d'intensité mais aussi au plan qualitatif par tous les symptômes d'accompagnement qui en sont la conséquence, même s'ils paraissent d'une autre nature que la tristesse à laquelle ils sont juxtaposés.

La tristesse, sentiment d'affliction, peut être le juste écho affectif à un événement pénible ; elle sera pathologique si elle est démesurée en intensité et en durée par rapport à celui-ci, mais plus encore si elle surgit sans cause apparente.

Excessive ou sans justification, la tristesse rentre alors dans le cadre de la dépression et suggère, dans sa mystérieuse dynamique, l'intervention de facteurs individuels de prédisposition et de fragilité dits facteurs de risques. Ceux-ci peuvent être génétiques, psychologiques, existentiels, biologiques et bien souvent intriqués.

La dépression : maladie fréquente et grave

L'universalité et la fréquence sont deux caractéristiques de la dépression, la troisième est la gravité.

La dépression n'est pas toujours évidente : « Fleuve invisible avec de sourdes plaintes » ; elle a ses masques, ses avatars, d'obscurs soubassements. Elle peut être camouflée dans une jovialité, l'action, sous une maîtrise olympienne et même dans le rire « trempé de pleurs qu'on ne voit pas ».

Sa fréquence apparaît dans les statistiques, auxquelles échappent, bien sûr, de nombreux cas. Il existerait dans le monde plusieurs centaines de milliers de déprimés. Selon certaines études, un quart des sujets est susceptible de se déprimer au cours de la vie.

Mais, facteur capital de gravité, les déprimés ont une forte propension au suicide. 13 000 suicides sont recensés par an en France et plus de 120 000 tentatives. Si tous ces actes ne sont pas liés à la dépression, plus de la moitié en serait la conséquence.

De plus, l'épidémiologie moderne tend à objectiver que les troubles dépressifs sont associés à une plus grande mortalité générale en dehors du suicide. La gravité de la dépression tient aussi à sa méconnaissance par l'entourage ou le déprimé lui-même. Celui-ci, englué dans son apathie, son désintérêt, sa résignation, n'exprime guère son état d'âme, mal perçu des autres. On rationalise, on banalise avec des interprétations rassurantes : fatigue, paresse, caprice, originalité... une véritable cécité semble toucher la famille, malgré parfois

un ensemble massif d'indices, dont elle prendra conscience, plus tard, après le suicide ou la tentative.

L'objectif essentiel de la prévention sera d'abord d'informer. C'est le but de plusieurs ouvrages destinés au public : *Le 36^e dessous*, de Pierre Daninos ; *La déprime*, de Jacqueline Michel ; *La dépression : fin du tunnel*, de Pierre Deniker ; *Je vais craquer*, de Henry Cuche et Alain Gérard ; *Comment vivre avec un déprimé ?*, de J.-M. Vanelle, et, plus récemment, *Je suis déprimé mais je me soigne*, rédigé par l'un de nous avec H. Cuche.

Ils aident à authentifier la maladie et dénoncent les erreurs à éviter.

La dépression si redoutable dans ses virtualités ! Et pourtant facile à guérir avec les thérapeutiques modernes psychologiques, chimiques et dans les formes graves l'électrochoc, traitement anodin malgré les fantasmes dont l'entourent l'ignorance ou la mauvaise foi.

Une dépression mélancolique bien traitée évolue en quelques semaines vers la guérison. Autrefois, on attendait sa résolution spontanée, mais après une durée de plusieurs mois et même un ou deux ans, quand la cachexie, le suicide n'y mettaient pas fin ou la mort subite, conséquence du stress de l'anxiété, des modifications neurovégétatives, endocriniennes et biologiques qui en découlent.

L'efficacité du traitement est certaine, sinon il faut reconsidérer le diagnostic et chercher les facteurs responsables de l'échec thérapeutique, souvent une affection organique sous-jacente ou des conditions affectives particulièrement néfastes.

Mais le pessimisme du déprimé lui ferme tout espoir. Le doute sur l'utilité d'un traitement est la règle, quand il n'a pas l'ampleur d'une idée délirante d'incurabilité. Le plus souvent aboulique et résigné, il ne croit ni n'aspire à sa guérison ; parfois désespéré ou d'une redoutable espérance... la mort « planant comme un soleil nouveau » (Baudelaire).

Chapitre I

LA DÉPRESSION ! QU'EST-CE ? OU LES DÉFINITIONS DES DÉPRESSIONS

Dérive sémantique du terme dépression

Détourné de son sens réel, le mot désigne dans le langage populaire toutes les altérations psychologiques, des troubles psychiatriques graves aux banales fluctuations de l'humeur ou du caractère. Le terme « dépression » a subi une sorte d'inflation, débordant, en deçà et au-delà, son véritable cadre, comme pour banaliser, anoblir peut-être, ce qui suggère « la folie » : état d'excitation, délires, schizophrénie, troubles intellectuels divers ou au contraire dramatiser les plus légères ombres de la vie : spleen, nostalgie, ennuis existentiels, déceptions sentimentales, difficultés professionnelles, etc., « ces interminables langueurs de l'âme que Flaubert appelait l'embêtement de l'existence » (B.-H. Lévy). Ainsi « dépression », « déprime », si répandues, corrompent la valeur sémantique du terme par une double extension vers ce qui est plus grave et ce qui l'est moins. La dérive verbale populaire réunit dans un concept généralisateur toute la psychiatrie et des états psychologiques qui n'en relèvent pas.

Les dépressions représentent une grande partie de la psychiatrie. Même limitée aux troubles de l'humeur, cette vaste catégorie demeure encore approximative.

Il est nécessaire de préciser le vocabulaire et particulièrement l'important clivage entre psychose et névrose, champs différents où s'insère la dépression.

Définition médicale de la dépression

En médecine, le concept « dépression » concerne une maladie particulière, avec des symptômes précis, caractéristiques, dont chacun l'évoque déjà, parmi d'autres troubles accessoires souvent associés. La maladie est variée dans son expression, sa gravité, son origine et cette diversité rend plus judicieux l'emploi du pluriel : les maladies dépressives. Elles demeurent circonscrites à certains constituants sémiologiques (ou symptômes) bien définis, mais dont aucun n'est isolément décisif. Il est en effet des réactions dépressives qui ne ressortent pas de la maladie dépressive malgré les indices (désarroi, tristesse, désespoir) qui la suggèrent. Ce sont des dépressions légitimes, en fonction de la conjoncture ou de l'événement.

Dans un sens médical rigoureux, la dépression est une maladie de l'humeur ou fonction thymique. Mais les études modernes estiment que les processus intellectuels sont également concernés et que la dépression peut retentir sur l'ensemble du fonctionnement de l'organisme.

Les fonctions psychiques

Les fonctions psychiques sont classiquement bien individualisées mais elles participent toutes secondairement au bouleversement de la personnalité des déprimés. « Tout l'homme est nécessaire à l'homme et dans chaque action l'homme entier se retrouve » (Jules Simon).

Dans le psychisme, on distingue plusieurs compartiments aux fonctions définies :

- l'intelligence juge et raisonne ;
- la volonté se détermine pour agir ;
- la sensibilité ou affectivité exprime ce qui est éprouvé ou désiré ;
- les instincts sont également impliqués. Leur corrélation est étroite ; tout acte psychique fait intervenir leur concours à des degrés divers.

La maladie mentale d'abord ponctuelle, circonscrite, retentit ensuite sur l'ensemble du psychisme mais par sa dominante elle est spécifique. Les démences altèrent les facultés intellectuelles. Les délires traduisent une erreur de jugement (interprétations) ou un trouble des perceptions (hallucinations). La schizophrénie semble d'abord une altération de l'affectivité, mais à la baisse, vers l'indifférence. La dépression exprime une perturbation de l'affectivité où dominent les troubles de l'humeur et, appoint récent, des processus intellectuels ou cognitions.

La fonction noétique ou vigilance. — Elle varie en efficence du sommeil profond à l'état d'éveil, conditionne l'attention au monde extérieur et en conséquence la qualité des activités cognitives (perception, réception et traitement des informations, jugement, synthèse, réponses adaptatives, verbales et comportementales).

La fonction thymique ou humeur. — La notion de thymie remonte à l'époque où la croyance situait le centre de l'humeur dans le thymus, glande qui disparaît à l'âge adulte. L'humeur « riche de toutes les instances émotionnelles et instinctives » sous-tend et conditionne la qualité des opérations intellectuelles ; elle colore le vécu personnel d'une tonalité agréable ou désagréable, joyeuse ou triste, « oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur » (Jean Delay).

Si la fonction noétique permet de reconnaître la perception et son sens, la fonction thymique lui confère une résonance intime. Les deux fonctions se complètent et se combinent comme l'objectif et le subjectif. L'humeur se situe dans la zone de l'affectivité ou ensemble de sentiments sur lesquels elle règne de façon inégale, car certains n'en semblent guère dépendants (l'amour maternel). L'humeur fait nos états d'âme, d'ombre ou de lumière, module l'éprouvé subjectif. Catalyseur de l'affectivité, l'humeur peut l'exalter, la corrompre et même, dans la dépression, l'anéantir.

L'humeur, parfois, libère les instincts (dans la manie) ou les inhibe (dépression).

L'état affectif peut aussi retentir sur l'humeur, comme l'exaltation de la passion amoureuse ou les douloureuses préoccupations de la jalousie. En somme, il y a entre l'affectivité et l'humeur une perpétuelle connivence et comme une réciprocité.

L'homme normal présente des variations de l'humeur ; elles sont plus marquées chez le sujet de constitution dite cyclothymique. Sur le versant pathologique, quand les oscillations de l'humeur ont trop d'ampleur, échappent au contrôle du jugement, c'est la psychose maniaco-dépressive.

Le concept d'hyperthymie pathologique

« Le battement alterné de joies et de peines est la cadence de l'existence » (Jean Guilton).

L'exagération des oscillations de l'humeur constitue un dérèglement hyperthymique. Il peut s'exprimer en deux directions contraires :

— vers le pôle de la gaieté, avec exaltation de l'idéation et de l'activité psychomotrice : c'est la manie ;

— vers le pôle de la tristesse, du pessimisme, de l'inertie : c'est la dépression.

A l'opposé, l'hypothymie est plutôt indifférence, repli sur soi, passivité par baisse de la réactivité émotionnelle.

L'hyperthymie est une exaltation de l'humeur, au contraire, l'hypothymie en est l'affaissement (schizophrénie).

L'hyperthymie avec sa « valence » (Porot) négative, l'envahissement de tristesse, son cortège d' « idées noires » menant au désespoir, avec la perturbation des fonctions cognitives constitue la dépression. Mais celle-ci, selon la combinaison des symptômes, la prédominance de certains, la source où elle puise, dessine des tableaux différents et permet de distinguer plusieurs types de maladies dépressives. La tristesse est la toile de fond de toute dépression. La dépression est un état d'âme aux ombres nuancées du crépuscule à la nuit, du normal au pathologique, du doute au désespoir, de la paresse à l'inertie, du spleen à l'angoisse, du désintérêt au désir de mort, de la délectation morose au suicide.

Il est des tristesses évoquant la dépression mais légitimes comme le *De Profundis* désespéré de Jean-Marc Bormart, poilu tué à la guerre de 14-18 :

*« Nous sommes si privés d'espoir,
La paix est toujours si lointaine,
Que nous savons à peine
Où se trouve notre devoir. »*

D'autres sont pathologiques par le degré, la durée, l'absence de cause, surtout quand elles bloquent l'activité et déforment le réel.

Il est difficile d'en évaluer l'intensité, parfois la sincérité ! Suspecte l'emphase romantique, jusqu'à la fanfaronnade : « Je te salue, ô mort, libérateur céleste ! » Mais elle peut exprimer une vraie souffrance ; c'est la ballade désolée de Gérard de Nerval, « le Ténébreux,

le Veuf, l'Inconsolé » dont le « luth constellé, porte le soleil noir de la mélancolie ». La tristesse est plus exploitée que la joie ; sans doute plus authentique et plus permanente chez l'homme.

Dépression : psychose et névrose

Dans la névrose, la réalité et la personnalité ne sont pas altérées ; les symptômes apparaissent au malade comme une enclave gênante et l'incitent au recours médical.

Dans la psychose, au contraire, toute la personnalité est perturbée, par une nouvelle réalité formée de fantasmes délirants entraînant la conviction du sujet qui n'a pas conscience de sa pathologie, par une modification profonde de l'affectivité et des relations au monde extérieur.

Psychose et névrose ont aussi des virtualités différentes. La psychose est un processus destructeur. Le mythe génie-folie n'a aucun réel fondement et ne répond à aucune connivence. Le génie n'évite ni n'engendre la folie et celle-ci n'en est jamais la source. Parfois, au début, la psychose « libère certaines instances subordonnées. Cette libération n'est pas création mais émancipation » (Jean Delay).

La dépression la plus redoutable est la dépression psychotique ou mélancolique. La dépression névrotique est différente et, pour l'identifier, il importe de bien connaître la personnalité particulière des névrosés.

La névrose n'est pas une dépression ; elle peut y conduire.

La dépression névrotique fait référence à une certaine fragilité de la personnalité. Cette forme de dépression, sans altération de la conscience, n'est pas l'aliénation mentale ou psychose.

Par contre, certaines mélancolies, la plupart, par la modification profonde de la personnalité et par la

perte du sens réel et la survenue d'idées délirantes, rentrent dans le cadre des psychoses dont elles ne sont qu'une catégorie. Ces dépressions psychotiques s'observent surtout au cours de la psychose maniaco-dépressive où le trouble de l'humeur paraît primordial.

Elle doit être différenciée des autres psychoses sans rapport avec les troubles de l'humeur ou non thymiques (psychoses hallucinatoire, paranoïaque, schizophrénique) ; mais il arrive parfois que des éléments dépressifs ou d'exaltation viennent se greffer accessoirement sur celles-ci, au cours de leur évolution.

Névroses. — Il est légitime et classique de différencier :

- *les névroses structurées* : phobique, d'angoisse, obsessionnelle, hystérique ;
- *les états névrotiques* : ils sont les plus fréquents et le lot habituel du médecin généraliste car ils allèguent, en premier lieu, des troubles physiques, traduction de leur mal-être psychologique. La névrose est le « langage organique de l'âme », l'expression organique d'un état affectif.

Les caractéristiques des névrotiques, à la fois dolents et exigeants, sans oblativité, d'un narcissisme éperdu, implorants dans la détresse, parcimonieux dans la reconnaissance, revendicateurs, parfois vindicatifs, donnent une coloration clinique particulière à la dépression névrotique.

Les états névrotiques, par leur altérité, déconcertent le médecin qui, dans une conception organiciste, les désigne par un vocabulaire obscur : neurotoniques, neurovégétatifs, dystonies neurovégétatives.

D'autres les considèrent comme des « malades imaginaires ».

Certains les classent dans la neurasthénie, terme ancien et ambigu, imprécise synthèse de toutes les plaintes sans atteinte organique. Les sujets sont

convaincus d'être malades et certains ont une propension au suicide : ainsi la neurasthénie englobe pour le public les états névrotiques, diverses formes d'hypochondrie, la dépression et, pour quelques auteurs, la psychasthénie.

Il est utile de bien identifier les névroses et de les différencier de la dépression qui peut les compliquer.

Maladies psychosomatiques. — Les états névrotiques ne doivent pas être confondus avec les maladies psychosomatiques.

Ils ont une cause commune psychologique : la dynamique de l'émotion.

L'émotion peut avoir un contre-coup :

- lésionnel : la maladie psychosomatique façonnée par les modifications biologiques du stress, redoutable démolisseur ; le taux du change est parfois élevé à la banque de l'émotion ! ;
- fonctionnel : les états névrotiques.

Les troubles fonctionnels sont soit allégués : céphalées, vertiges, asthénie, etc., soit vécus, apparents, dans l'hystérie de conversion : contractures, aphonie, paralysies, etc.

Les divers troubles fonctionnels de la réponse névrotique à l'émotion sont considérés comme un mode de défense du « moi » ; ils correspondent à une régression affective de la personnalité qui pourrait prédisposer aux ruptures dépressives.

Les réactions névrotiques, modes d'aménagement de l'émotion, libèrent celle-ci, l'épanchent, en déchargeant la dynamique par une extériorisation parfois théâtrale. Au contraire, le self-contrôle la contient ; elle devient alors un agent stressant destructeur, catalysant diverses maladies psychosomatiques ou une rupture dépressive. Des auteurs ont établi des analogies entre

maladies psychosomatiques et ruptures dépressives qui pourraient être issues des mêmes germes.

Sens des névroses et de la dépression névrotique. — Il est important de comprendre le langage névrotique, de rechercher le sens du symptôme et son origine. En effet, la névrose implicitement fait souvent référence au passé.

Pour les psychanalystes, elle renvoie à un contentieux affectif venu de l'enfance qui potentialise les résonances du présent. Cependant, il est des névroses actuelles, conséquence d'événements que le sujet ne peut assumer, car l'homme est fragile, même adulte, même psychanalysé. « Il n'y a pas de grandes personnes », disait Malraux.

Souvent, la dépression névrotique est la conséquence d'une situation conflictuelle, à rechercher systématiquement. Il en est de particulièrement ambiguës, nées de la « cohabitation de sentiments contradictoires » (Dostoïevski). Etats intermédiaires faits d'aspirations opposées : la fille diffère le mariage, hésite entre l'enfance où elle n'est plus et l'âge adulte où elle n'est pas encore.

Dans de telles situations de contrainte et d'ambiguïté affective, la dépression peut être l'inévitable issue. Le danger est d'ignorer la dépression, de privilégier la névrose et ainsi de favoriser sa chronicité ; le médecin se trompe, le psychanalyste s'obstine, le malade s'y prête ! Le médecin, abusé, méconnaît souvent la nature dépressive des troubles allégués. Le malade inaugure alors un long périple médical d'examens, d'analyses, de spécialistes, aboutissant parfois à des solutions chirurgicales. Ainsi, la névrose, par d'obscures connivences, tisse de tragiques destins.

La dépression névrotique. — La dépression, fléchissement de l'humeur et de l'activité, peut apparaître dans les névroses structurées ; elle respecte, de façon habituelle, leurs particularités. Elle est surtout fréquente dans les états névrotiques.

La personnalité, soudain ou progressivement assombrie par les aléas existentiels, parfois futiles, laisse sourdre des défaillances, surgir de tristes affects... Il est difficile de dire où la dépression névrotique commence et d'en fixer les limites... Elles ne sont pas toujours les mêmes pour le médecin et certains malades sont portés à dramatiser leurs alarmes, à les majorer ; de banales palpitations sont une crise cardiaque ; l'asthénie, un peu de tristesse, constituent déjà une « dépression ».

Le médecin souscrit parfois à cette évaluation inflationniste pour justifier par la « dépression » un arrêt de travail.

La dépression névrotique est dite psychogène alors que la mélancolie est considérée comme endogène. La dépression des névroses se distingue par la personnalité sous-jacente où le moi est prévalent, peu dévalorisé. A l'opposé de la mélancolie, les propensions au suicide sont plus ambiguës, moins prégnantes.

Un trait est commun aux deux formes de dépression, la tristesse, mais à des degrés divers, avec des conséquences différentes : dans la rupture dépressive, la névrose a perdu la joie de vivre, la psychose le goût de vivre...

La tristesse dans la dépression névrotique oscille de la morosité au désespoir, mais riche d'inflexions diverses : inquiétude, pessimisme, note d'hypocondrie, jamais délirante, légitimée par l'échec des traitements, amertume des exigences non satisfaites, découragement, lassitude, renoncement à l'effort, car la fatigue est constante, qui ne revêt cependant pas l'ampleur de l'inhibition psychomotrice, véritable blocage insurmontable. La dépression névrotique présente une image dolente d'affliction. Parfois, quelques lueurs d'agressivité : bouderie, impatience, jalousie. Mais quel art de circonvenir, d'alarmer et surtout d'accaparer.

La dépression névrotique est une sorte d'épopée

narcissique, sur fond d'inquiétude, de désarroi, avec sa stratégie d'apitoiement, de chantage parfois, d'insurrection et ses conquêtes : les bénéfices secondaires.

Les fonctions intellectuelles ne sont pas perturbées ; même l'appoint habituel d'anxiété n'altère pas le sens du réel.

Ainsi la dépression névrotique est dans la trajectoire de la personnalité et non, comme dans la dépression psychotique, une effraction dans la personnalité soudain démolie.

Mais la conception dualiste de la dépression névrotique-psychogène et psychotique-endogène est de plus en plus remise en cause. Tous les intermédiaires sémiologiques s'observent, les deux registres se chevauchent entre leurs tableaux les plus explicites : des ruptures névrotiques semblent inexplicables et des dépressions psychotiques succèdent à des événements traumatiques. Certains tableaux cliniques empruntent des masques mixtes.

L'hypocondrie

L'hypocondrie, « exagération du souci de sa propre santé » (Abadie), a des significations, des degrés, des visages différents.

Parfois pittoresques comme Argan dans sa vigilance alarmée — car il succomberait s'il passait trois jours sans prendre soin de lui — et sa stratégie prévisionnelle : avoir un gendre et des alliés médecins pour « s'appuyer de bons soins contre la maladie », malgré la réticence impertinente de Toinette : « Elle a l'effronterie de dire que je ne suis pas malade. »

La panoplie narcissique des états névrotiques est souvent teintée d'hypocondrie, dolente, sollicitieuse ou revendicatrice, mais labile ; par contre étale, envahissante dans la névrose hypocondriaque. Les névroses structurées peuvent en être également affectées avec une image différente selon la nature, le mécanisme psy-

chologique propre à chacune (névrose phobique, obsessionnelle, d'angoisse, hystérique).

Mais ces diverses alarmes concernant la santé traduisent seulement une mauvaise évaluation du vécu. Elles n'expriment pas un égarement du jugement, ni un trouble profond de la personnalité comme dans la mélancolie où l'hypocondrie, même discrète, évoque la dérive délirante.

Polymorphisme des dépressions

L'expression diversifiée des dépressions, leur nature, leur gravité différentes, leur origine, la personnalité du sujet fondent le polymorphisme des dépressions et en distinguent les variétés.

La dépression peut s'intégrer dans le cadre de la psychose maniaco-dépressive (PMD). D'autres peuvent être consécutives à un événement ou à un épuisement physique ; ce sont des dépressions réactionnelles.

Lorsque la dépression révèle une maladie organique, comme le vieillissement cérébral, on la désigne par le vocable de symptomatique, car elle est révélatrice d'une autre affection.

Les différentes formes de dépression peuvent être groupées en quatre rubriques :

- les dépressions psychotiques, ou mélancolie, appartenant essentiellement à la psychose maniaco-dépressive (PMD), dites endogènes, considérées, abusivement, comme peu influencées par les événements extérieurs ;
- les dépressions névrotiques où la personnalité joue un rôle primordial, dites psychogènes ;
- les dépressions réactionnelles à un événement (deuil, retraite, déménagement, etc.) ;
- les dépressions symptomatiques.

Cette diversité des dépressions rappelle la formule énigmatique de Platon (J. Guitten) « un et plusieurs »,

mais une diversité « assumée dans l'unité plus haute », le dérèglement de l'humeur.

Les dépressions, malgré leur diversité selon les causes, les aspects et les évolutions, seront nécessairement dans la conception classique :

- soit de nature névrotique-exogène ;
- soit de nature psychotique-endogène.

Les dépressions réactionnelles et les dépressions symptomatiques pourront paraître de l'une ou l'autre nature.

Mais certains auteurs défendent l'unicité de nature des maladies dépressives et réfutent l'opposition psychotique névrotique ; les deux formes ne seraient que les deux versants graves ou modérés d'un même trouble.

La psychiatrie américaine, dans un souci de simplification, et surtout d'efficacité, a une approche différente. Le *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux* élaboré par l'Association américaine de psychiatrie (DSM 3 et version révisée) envisage exclusivement l'aspect descriptif des symptômes sans considération de nature ou de cause.

Les troubles dépressifs sont distingués en « majeurs », d'une part, c'est-à-dire caractérisés, et en « dysthymiques », d'autre part, pour les manifestations dépressives atténuées et plus chroniques.

Illustration clinique de divers types de dépression par d'authentiques exemples

Une psychose maniaco-dépressive. — M. André S..., 55 ans, aux affaires prospères, est adressé car son comportement a changé depuis un mois. Il dort mal, se réveille tôt, a perdu l'appétit et maigri. Il ne s'intéresse plus à ses enfants, au foyer, au golf qui le passionnait.

Anxieux, préoccupé car « il ne pourra pas payer ses

traites, ni ses employés et la faillite est inévitable», à cause « de mauvaises affaires et de contrats mal évalués ».

Seule responsable de la catastrophe inéluctable : son incompétence !

A-t-il envie de se suicider ? Il reconnaît sur un ton confidentiel qu'il y pense « pour éviter le déshonneur » mais « il n'a pas le courage ». D'après la femme, la trésorerie est saine et les contrats passés sont habituels. Manifestement, les fermes réassurances de l'épouse laissent M. S... dubitatif et résigné à l'incompréhension de son entourage. Il accepte d'être hospitalisé le lendemain « pour un bilan car il n'est pas malade ».

L'investigation révèle deux épisodes antérieurs qui n'avaient pas donné lieu à une consultation spécialisée. Cinq ans auparavant, M. S..., fatigué, avait maigri, digérait mal. Il craignait un cancer. L'activité professionnelle, habituellement vécue dans l'enthousiasme, était devenue pesante. Il avait interrompu le golf et refusait toutes les invitations malgré sa propension à la convivialité. Le médecin avait prescrit des fortifiants.

L'état s'était amélioré en trois à quatre mois. Il y a deux ans, par contre, M. S... a présenté une période de « très grande forme », le sommeil raccourci, M. S... se levait tôt, se montrait joyeux et chaleureux avec tous, décuplant ses activités professionnelles et de loisir ; il avait décidé d'agrandir l'affaire malgré les conseils des gestionnaires.

Son bavardage incessant, son hyperactivité, de nombreuses invitations avaient alors épuisé Mme S... M. S... s'était apaisé après deux mois.

La grand-mère paternelle aurait fait plusieurs séjours en asile psychiatrique et serait morte vers 55 ans en se noyant à la Toussaint.

Dans la nuit avant l'hospitalisation, Mme S..., réveillée par un bruit, trouve son mari allongé par terre, une ceinture de robe de chambre nouée autour du cou et l'hospitalise immédiatement.

L'épisode actuel est une dépression mélancolique avec délire de ruine, sentiment d'incurabilité et troubles dits biologiques : insomnie, perte de l'appétit, amaigrissement.

La tentative de pendaison illustre la permanence et l'imprévisibilité des propensions suicidaires des mélancolies.

L'accès cinq ans plus tôt évoque un épisode mélancolique : inhibition, perte du tonus, préoccupations à la limite d'un délire d'incurabilité (cancer).

L'épisode plus récent suggère un discret épisode de manie (hypomanie) : activités décuplées, initiatives nombreuses, optimisme et dynamisme excessifs. M. S... présente une psychose maniaco-dépressive cyclothymique avec trois accès. L'aspect familial de la PMD est habituel : la grand-mère a probablement présenté des dépressions et un suicide car la baignade à la Toussaint reste exceptionnelle sous nos climats.

Une dépression névrotique. — Mme Dorothee W... a 36 ans, un mari attentionné et deux enfants affectueux. Elle est hospitalisée après avoir absorbé des tranquillisants prescrits pour « son anxiété ». Sa santé est, en effet, depuis de nombreuses années, source de périlleuses interrogations. Elle est fatiguée, surtout le matin, sujette à maux de tête, bourdonnements d'oreille, palpitations, sans appétit, sommeil irrégulier et jamais réparateur. Les activités sont accomplies avec peine et lenteur, « elle ne peut se concentrer et n'a pas d'énergie ». Elle se décrit comme « émotive, anxieuse, sensible » ; les nombreux examens physiques, biologiques et radiologiques négatifs ne peuvent la rassurer. Une promotion professionnelle proposée à son mari imposait une absence hebdomadaire. Mme W... s'opposa à ce projet qui la privait de la sollicitude conjugale et de l'aide ménagère du mari. Elle redoutait une fatigue supplémentaire et la

solitude. M. W..., après tergiversations, accepta la promotion.

L'échéance du départ s'approchant, Mme W... devint « maussade, triste, désespérée ». L'ennui et l'inquiétude familiers devinrent plus prégnants, les larmes et les récriminations plus fréquentes.

Tendue, maussade, irritable, elle n'arrivait plus à assumer les charges de la maison et des enfants. « Elle n'en avait ni le goût, ni la force. » Les difficultés de sommeil empirèrent et des nausées imposèrent une restriction alimentaire. Mme W... était malheureuse, prostrée, geignarde, « dégoûtée de tout ». La veille du départ du mari, elle absorbe un tube de tranquillisants. Le mari la retrouve le lendemain dans un sommeil profond. Le SAMU la dirige vers la réanimation qui l'adressera plus tard, lucide, en psychiatrie.

Le mari a dû surseoir à sa prise de fonction.

Mme W... illustre la dépression névrotique. Elle présente les caractéristiques de la personnalité névrotique : émotive, dépendante de l'environnement, préoccupée à outrance de sa santé, aux troubles fonctionnels multiples, intolérante aux frustrations et égocentrique. La « maladie » est un alibi inconscient pour dominer le mari et les enfants, capter leur sollicitude et se soustraire aux contraintes du quotidien.

Le départ du mari et le refus d'y renoncer sont pour Mme W... une intolérable frustration et une profonde blessure narcissique puisque la promotion professionnelle semble préférée à sa santé. Une participation dépressive (tristesse, ennui, dégoût) infiltre les symptômes névrotiques qu'elle majore. La tentative de suicide ne fut pas préméditée, mais Mme W... « ne savait plus quoi faire, voulait ne pas penser et dormir ». Le suicide n'est pas ici une volonté déterminée de mort comme dans la mélancolie mais la seule issue dans une situation d'impasse. Il authentifie le désarroi et remet en cause la situation non acceptée. Au travers du bou-

leversement affectif et de la culpabilisation qu'elle suscite dans l'entourage, la tentative de suicide est aussi une réaction agressive, une vengeance implicite à la frustration infligée. Le suicide de la dépression névrotique est auréolé d'ambiguïtés dans ses modalités et ses significations ; il est autant un geste de dépit que de désespoir.

Une dépression réactionnelle. — M. Jean B..., 42 ans, est amené par son épouse pour des troubles survenus après une déception professionnelle.

M. B..., ingénieur commercial, est engagé à 25 ans dans une entreprise de construction. Il y connaît son épouse, secrétaire de direction, et accède à des postes de responsabilité. Le ménage a deux enfants. Alors que rien ne le laissait prévoir, la direction licencie M. B... dans le cadre des restructurations liées à une fusion, mais avec de confortables indemnités. L'annonce du licenciement est ressentie par M. B... comme une injustice et une effroyable catastrophe. Depuis, il a perdu l'appétit, rumine sans cesse l'événement, est angoissé, tendu. Il ne parle presque plus, tant au bureau où il accomplit son dernier mois qu'à la maison. L'intérêt porté habituellement à la famille semble englouti derrière le drame du licenciement. Des larmes surgissent à la moindre sollicitation. Les activités professionnelles sont devenues pénibles et accomplies avec lenteur. Il est désespéré malgré les propos rassurants de son épouse sur leur situation financière, sur les propositions professionnelles nombreuses que ses références susciteront. Aucun argument n'atténue la douloureuse affliction de M. B... Après la cessation des fonctions, il reste à la maison, regarde de façon distraite la télévision, refuse de répondre au téléphone et de faire passer des annonces de recherche d'emploi. Tous les subterfuges employés par l'épouse pour l'extraire à son apathie et à sa tristesse demeurent vains. Un matin, il évo-

que la possibilité d'en finir. Alors, Mme B... comprend « qu'il est malade ». M. B... n'avait aucun antécédent personnel ou familial de dépression et ses caractéristiques psychologiques antérieures n'évoquaient pas un terrain à risque. L'événement traumatique, le licenciement, semble avoir été déterminant dans la survenue de la dépression. Celle-ci est dite réactionnelle ou secondaire pour signifier qu'elle succède à une vicissitude.

Une dépression symptomatique. — Mme Juliette C..., 70 ans, était une retraitée heureuse. Son mari, de 73 ans, est bien portant et fort attentionné. Enfants et petits-enfants leur sont très attachés. Pourtant, depuis un an, de façon insidieuse, le comportement et le caractère de Mme C... se sont modifiés. Mme C..., cuisinière émérite, fière de son art, a perdu progressivement le goût à la cuisine et s'est même résignée aux conserves qu'elle abhorrait autrefois : « elle n'a plus le tonus, la même résistance », dit-elle. L'intérêt pour les dramatiques à la télévision, pour les mots croisés et les après-midi de thé avec deux amies s'éteint progressivement. Elle a perdu l'enthousiasme et l'initiative. Les jours s'écoulaient moroses. Elle évoque avec nostalgie le passé ; l'avenir la laisse indifférente. Elle pleure facilement : « Je ne sais pas pourquoi. » Triste ? « Pas vraiment, mais pas gaie. »

*« C'est bien la pire peine, de ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de
peine... » (Verlaine).*

A-t-elle envie du suicide ? « Pas du tout, mais elle n'a plus grand-chose à attendre de la vie. »

Elle mange « sans appétit » et éprouve des difficultés à se mettre en route le matin. « Je deviens un peu faimée », commente-t-elle. Elle ne formule aucun grief

contre le mari, la famille ou la situation, reconnaît même certains privilèges.

C'est le tableau d'une dépression avec désintérêt, apathie et ralentissement psychomoteur. La tristesse n'est pas au premier plan et les idées de suicide n'existent pas. Mais le monde extérieur et les centres d'intérêt ont perdu leur attrait de jadis. Tout paraît neutre et démotivant. Son médecin l'adresse en psychiatrie où un traitement antidépresseur entraîne en deux mois une amélioration notable. Si la vie exerce à nouveau une certaine fascination agréable, Mme C... se plaint de difficultés de concentration intellectuelle, d'une fatigabilité à la lecture, de perdre le fil des histoires à la télévision, de difficultés de mémoire. Les investigations cliniques et les tests objectivent une perte excessive des capacités intellectuelles qui évoque un processus de détérioration intellectuelle du type maladie d'Alzheimer. L'évolution ultérieure confirmera le diagnostic. La dépression a inauguré la sémilogie de la détérioration intellectuelle et a précédé les troubles intellectuels. La faillite de la fonction thymique a précédé celle des processus cognitifs. La dépression ne résume pas alors la maladie mais elle constitue le premier symptôme révélant le processus de détérioration. Cette dépression est symptomatique.

Ces exemples illustrent quatre types de dépression différents dans leur traduction clinique, leurs facteurs déclenchants et leur évolution.

Elles suggèrent en outre une différence intrinsèque de nature : les unes révélant un déterminisme génétique et dites endogènes, les autres exprimant une fragilité de la personnalité face aux événements et dites exogènes.

Chaque dépression, selon sa nature, a une expression sémilogique, mais il existe des masques trompeurs. Les antécédents personnels et familiaux, les circonstances et modalités du début, surtout l'évolution permettent de situer la dépression dans son appartenance catégorielle.

Chapitre II

COMMENT S'EXPRIME-T-ELLE ? OU LA SÉMIOLOGIE DES DÉPRESSIONS

Les masques cliniques des dépressions sont d'une immense variété selon la combinaison des différents signes, leur intensité ou leur prévalence. Toute une imagerie peut être esquissée d'un voile léger de morosité et de perte d'entrain, au désespoir extrême, à l'attrait de la mort.

Certains symptômes sont habituels et leur présence simultanée façonne l'image classique de la dépression. A côté des formes typiques, il existe des formes trompeuses, des formes émoussées ou restreintes à un ou deux symptômes (dites pauci-symptomatiques).

I. — Tableau classique des dépressions

Toute dépression comporte une perturbation thymique ou affective qui retentit sur l'activité intellectuelle et motrice, génère l'anxiété et perturbe les fonctions instinctives.

1. Trouble thymique ou humeur dépressive. — Le trouble de l'humeur apparaît de façon insidieuse ou de

manière brutale d'un jour à l'autre. Un vague sentiment d'ennui, de morosité peut être le prélude à une tristesse plus prégnante. Le pessimisme douloureux envahit le vécu du sujet avec sa moisson de sentiments de nostalgie, de dégoût, d'abattement, de dévalorisation, d'autodépréciation. Le pessimisme déforme la vision de soi-même (autodépréciation, parfois culpabilité) et de la vie. Les choses, les autres ne présentent plus d'attrait. Les centres d'intérêt naufragent. Le déprimé ne ressent plus motivations et plaisirs. Ainsi, dans la dépression coexistent des sentiments douloureux (hyperthymie) et une indifférence vers l'extérieur (anesthésie affective).

Dans la dépression, les modulations affectives intimes et permanentes, en écho aux sollicitations extérieures situationnelles, sombrent dans une gangue monolithique de tristesse douloureuse et de dégoût. Le passé, le présent et le futur deviennent infiltrés de regrets, de remords, d'inquiétude.

L'incapacité à envisager un avenir, à élaborer des projets est très caractéristique de la dépression. Les déprimés expriment de manière plus ou moins explicite, tout à la fois :

- la tristesse, le désespoir ;
- l'ennui pour toute activité, même de loisir ;
- l'absence de motivations ;
- des sentiments d'incapacité et d'autodépréciation, surtout dans la dépression psychotique ;
- la perte d'intérêt pour la vie qui débouche parfois sur un désir de mort, formulé ou caché ;
- l'évaluation pessimiste de l'avenir où la situation paraît inexorablement bloquée.

La tristesse douloureuse prend parfois une intensité intolérable, paralysant toute réflexion, anesthésiant toute sensation : c'est la douleur morale assez spécifi-

que de la dépression endogène qui constitue un puissant catalyseur pour le suicide.

2. Inhibition psychomotrice. — C'est une perte de l'élan vital ; les activités motrices et intellectuelles sont globalement ralenties. L'initiative paraît abolie. Toute activité s'effectue avec lenteur et effort ; elle est ressentie comme source de fatigue. En effet, la fatigue et le désintérêt semblent s'allier pour freiner les opérations psychiques et motrices ou les rendre impossibles. La mimique est lente, pauvre dans un faciès figé (hypomimie). L'expression du visage peut souvent exprimer la tristesse. La voix est éteinte, sans relief ni modulation, monocorde. Le geste est lent, souvent incomplet (bradykinésie). La démarche semble pesante.

Un ralentissement psychique accompagne la perturbation motrice. L'idéation est ralentie (bradypsychie), la parole dépourvue de rapidité et de vivacité, traînante, parfois geignarde. Le discours apparaît terne, rudimentaire, indigent. Les réponses sont parcimonieuses et elliptiques.

Le contenu idéique semble réduit ; la pensée se focalise sur une idée stéréotypée à tonalité dépressive.

L'association des idées est médiocre, la compréhension paraît obscurcie. Le déprimé répond avec lenteur. Les souvenirs sont imprécis et leur évocation laborieuse. L'attention spontanée au monde extérieur paraît engloutie, corollaire du désintérêt, l'attention provoquée mobilisée comme avec peine. Le jugement subit une distorsion sous l'influence du trouble de l'humeur dans le sens d'une péjoration globale. Tout semble péniblement appréhendé et intégré dans de sombres perspectives. Le déprimé mélancolique est résigné ; par contre, le déprimé névrotique évoque les possibles remèdes qui sont toujours des demandes vers autrui, souvent des exigences. Quelquefois, le discours paraît prolix, la mimique plus expressive,

pathétique avec une apparente exacerbation idéique remplaçant l'inhibition psychomotrice, notamment dans certaines dépressions névrotiques. Mais derrière cette façade, chacun allègue toujours une fatigue insurmontable.

L'inhibition psychomotrice quasi constante s'exprime en formules désabusées, « manque d'énergie, de goût, de tonus, d'entrain, de vivacité, de dynamisme, fatigue, lassitude, abattement, épuisement, anéantissement ».

Tristesse douloureuse et perte du tonus vital sont deux caractéristiques fondamentales de la dépression.

3. Anxiété et troubles du caractère. — L'anxiété est toujours associée à la dépression.

L'anxiété, sentiment pénible de crainte et d'appréhension, fait redouter de virtuels malheurs, alors que, pour le pessimisme dépressif et particulièrement mélancolique, les catastrophes sont actuelles ou inévitables.

L'anxiété dans la dépression subit des fluctuations quantitatives ; ses paroxysmes peuvent induire le suicide pour fuir l'angoisse éprouvée.

Elle peut aussi s'exprimer par une irritabilité, des manifestations caractérielles agressives, quelquefois une agitation.

Dans la dépression névrotique, elle est consciente et proclamée ; dans la mélancolie son intensité est variable subissant des acmés, sources de *raptus* suicidaires ou de pétrifications. Sa sémiologie s'enrichit de ses concomitantes physiques, tremblement, bouche sèche, oppression thoracique, fièvre, spasmes divers.

4. Les symptômes physiques. — Ils sont très fréquents. Certains sont peu spécifiques, d'autres plus évocateurs ; ils peuvent masquer les symptômes et induisent alors de nombreuses investigations médicales infructueuses. Les troubles physiques caractérisés par

leur diversité sont différemment combinés selon la nature de la maladie et les sujets.

A) *Les troubles du sommeil* sont constants. L'insomnie est la règle, différents types pouvant être observés :

- l'insomnie par réveil précoce, vers 3 ou 4 h du matin, avec angoisse, considérations lugubres, appréhension de la journée, est particulièrement évocatrice de la dépression, notamment endogène ;
- l'insomnie d'endormissement avec de pénibles et incoercibles ruminations en évoque plutôt la dimension anxieuse ;
- parfois, elle procède des deux phénomènes intriqués ;
- les réveils fréquents dans la nuit majorent la réduction du sommeil.

Elle conditionne la fatigue et, pour le déprimé, le sommeil n'est jamais réparateur.

A l'inverse, quelques formes s'accompagnent d'un allongement du temps de sommeil (hypersomnie) mais celui-ci n'est nullement ressenti comme bienfaisant.

B) *Les troubles digestifs* sont dominés par l'anorexie, presque constante. Le dégoût pour la nourriture est en règle global. L'appétit a disparu et les mets paraissent insipides. Cette perte du goût illustre l'incapacité à ressentir le plaisir.

L'amaigrissement, conséquence de l'anorexie, caractérise certaines dépressions endogènes. Les déprimés se plaignent souvent de nausées, de spasmes à l'estomac, de constipation ou de diarrhée, de lourdeur épigastrique.

Quelquefois, au contraire, c'est le besoin impérieux de manger beaucoup, avec une certaine voracité : cette *boulimie* serait réactionnelle à la dimension anxieuse prononcée.

C) *Les troubles sexuels* permanents, d'intensité diverse, s'expriment par un désintérêt pour la sexualité ; frigidité chez la femme, impuissance chez l'homme, plus ou moins prononcées. Mais les difficultés sexuelles sont rarement rapportées spontanément, sinon par le conjoint, qui en prend parfois ombrage.

Mais la sexualité du déprimé n'est pas toujours diminuée, amortie, éteinte. Dans certaines mélancolies, elle émerge en des comportements sexuels débridés et inhabituels, mystérieuse alchimie où le mélancolique suicidaire se livre à l'exhibition et parfois la femme à la prostitution. Chez celle-ci, l'« univers morbide de la faute » est fait d'images, de pensées sexuelles obsédantes. Cette effraction de l'érotisme dans la personnalité, surtout chez une croyante, soulève une culpabilité désespérée et suicidaire.

D) *Les autres troubles somatiques* sans support organique, qualifiés de fonctionnels, sont variés : palpitations, vertiges, tremblements, spasmes, « boule dans la gorge », « serrement du cou », « striction thoracique », douleurs, notamment de la nuque et de la colonne vertébrale, maux de tête, troubles sensoriels, mouches volantes, vision floue, bourdonnements d'oreille.

Ils transposent, sur le plan physique, le malaise psychique subjectif et égarent vers de longs parcours dans la médecine somatique.

Ils s'observent dans toutes les formes de dépression. Ils seraient plus extériorisés dans les dépressions névrotiques mais se rencontrent aussi dans les états anxieux.

Ils peuvent rendre le diagnostic ardu entre ces diverses affections. Plus permanents dans les névroses et les états névrotiques, ils suggèrent une dépression s'ils sont d'apparition récente ou se sont brusquement majorés.

5. **Le désir de suicide.** — L'attrait pour la mort est presque une constante de la constellation dépressive. Le désir de suicide n'est pas toujours ressenti ou exprimé mais parfois volontairement caché. Son intensité varie selon le type de dépression et les moments. Un déprimé peut n'avoir aucune propension à se tuer un soir et le lendemain matin en ressentir l'impérieuse nécessité.

Ces fluctuations dans la journée sont parfois sans raison apparente comme dans les dépressions endogènes, parfois en réponse aux événements extérieurs comme dans les dépressions psychogènes. Mais elles demeurent dans l'ensemble imprévisibles.

Le projet suicidaire peut être formulé par le déprimé mais souvent l'entourage demeure naïvement incrédule. Parfois, il est confié au médecin avec un alibi restrictif, « il n'aura pas le courage ». Certains sujets nient toute intention de se donner la mort, parce qu'ils n'en éprouvent pas, ou par honte, ou pour ne pas être entravés dans leur détermination. Parfois, dans la dépression endogène, le suicide est prémédité et soigneusement caché. Mais il existe aussi des émergences brusques de pulsions suicidaires, dénommées « *raptus* suicidaire », sous-tendues par l'anxiété. Dans les dépressions inhibées, l'inhibition psychomotrice constituerait un frein au passage à l'acte, mais elle peut disparaître transitoirement (levée de l'inhibition) et en permettre la réalisation. Il est très difficile d'évaluer le risque suicidaire qui serait plus manifeste dans les dépressions endogènes, dans les dépressions sévères et anxieuses. Toute quantification reste aléatoire, malgré des instruments d'évaluation précis (échelles d'évaluation), car la gravité est mouvante dans le temps, parfois d'une minute à l'autre.

II. — Expressions et types de dépressions

Le profil clinique d'une dépression dépend en partie de sa nature endogène, ou psychogène ou réaction-

nelle, ou sans cause apparente ou symptomatique. Ses différents symptômes peuvent suggérer son appartenance mais aucun n'est spécifique ; leur regroupement devient évocateur.

Pour préciser la nature d'une dépression, il faut s'enquérir des antécédents personnels et familiaux, du mode de début, de la personnalité avant la maladie, des événements ou des problèmes potentiellement en cause. Une dépression brutale sans cause apparente, chez un sujet ayant des antécédents familiaux de dépression, est probablement endogène. Une dépression suivant une contrainte, chez une personne fragile, immature, exigeante, risque d'être une dépression névrotique.

Mais la question de la nature d'une dépression est complexe car il existe d'authentiques mélancolies au cours des névroses et d'autres réactionnelles à un événement.

1. **La dépression endogène** typique est caractérisée par une douleur morale patente contrastant avec une indifférence affective (anesthésie affective) pour l'extérieur, un pessimisme foncier, une inhibition marquée, des thèmes d'autodévaluation et d'auto-accusation, des idées délirantes, de ruine, de catastrophe, d'incurabilité, une insomnie par réveil précoce, une anorexie avec amaigrissement, un dégoût de la vie inaccessible à toute argumentation. La fluctuation des symptômes dans la journée est particulière dans les dépressions endogènes : très marqués le matin, ils tendent à s'estomper en fin de journée. Dans l'ensemble, le déprimé mélancolique méconnaît l'aspect pathologique de son état et récuse tout recours médical, jugé inutile.

2. **La dépression névrotique ou psychogène** est plus volontiers caractérisée par l'anxiété, l'irritabilité, les plaintes fonctionnelles multiples, l'absence d'idées délirantes et une demande d'aide.

L'auto-apitoiement remplace l'auto-accusation. A la différence du mélancolique, le déprimé névrotique incrimine souvent des événements ou autrui dans la survenue de son état et s'avère capable de suggérer des stratégies susceptibles de l'améliorer.

Contrairement à la dépression endogène, la tristesse et l'angoisse tendent à s'exacerber le soir ; les troubles de l'endormissement sont fréquents.

3. L'expression de la **dépression symptomatique** est fonction de la maladie qui évolue en arrière-plan. Souvent, la fatigue et le ralentissement psychomoteur sont marqués, les plaintes somatiques peuvent être liées à l'affection sous-jacente.

Parfois, la composante anxieuse est assez prononcée, notamment dans les dépressions au cours de maladies graves, invalidantes et dans certaines affections des glandes endocrines (comme dans l'hyperthyroïdie ou maladie de Basedow).

Quel que soit le registre où se situe la dépression, le trépied : tristesse-désintérêt, ralentissement, anxiété, demeure primordial et fonde le diagnostic. Les autres symptômes définissent la gravité et la nature de la dépression.

III. — Les divers aspects de la dépression

La dépression peut s'exprimer par :

- des tableaux psychiatriques francs (agitation, délire, confusion) dont la nature dépressive n'est pas évidente ;
- des symptômes larvés, sommaires, peu évocateurs (somatiques, insomnie, troubles sexuels isolés, etc.) pouvant faire occulter la nature dépressive ;

- par un ou deux signes prévalents faisant écran aux autres et simulant une autre pathologie (anxiété, névrose).

1. Variétés cliniques de la mélancolie. — Certaines mélancolies sont atypiques ; le noyau dépressif caractéristique est englouti derrière une sémilogie qui semble d'une autre nature.

A) Dans la *mélancolie stuporeuse*, le malade est figé, mutique, sans initiative, en dehors du monde, comme pétrifié de douleur.

Parfois, de sourds gémissements transcrivent la douleur morale, immergée derrière la sidération mortrice.

La mélancolie stuporeuse peut être confondue avec les stupeurs :

- émotionnelles après un traumatisme intense ;
- d'origine cérébrale (encéphalite), mais les investigations neurologiques sont négatives ;
- d'une confusion mentale ; le malade est alors perplexe, étonné, plus égaré que douloureux.

B) Les *mélancolies délirantes* peuvent en imposer pour des états délirants dont le traitement diffère de celui de la dépression. Toute mélancolie est en réalité délirante puisque le jugement est altéré par le pessimisme. Le terme de mélancolie délirante est réservé aux dépressions où le délire est prééminent, occultant tristesse et inhibition. Les thèmes du délire s'inscrivent généralement dans la lignée mélancolique : délire de culpabilité, de ruine, de déshonneur, de damnation ; leur contenu évoque l'appartenance dépressive. Ces thèmes délirants sont qualifiés de « congruents à l'humeur » (dans le DSM 3). Les mélancolies pseudo-hallucinatoires peuvent être confondues avec les psychoses

hallucinatoires chroniques. Le mélancolique affirme avoir entendu des injures et des menaces, souvent de mort ; il s'agit plutôt de représentations imaginatives nées de l'attente anxieuse, revêtant les apparences de la sensorialité. Le mélancolique imagine qu'on veut le châtier, le tuer et croit entendre les verdicts condamnatoires. Une mélancolique assurait percevoir les voix d'un tribunal qui délibérait à son sujet : la sentence associait le supplice, l'exécution par fusillade et pendaison.

Les mélancolies de persécution sont plus trompeuses : les préoccupations peuvent être formulées avec une conviction qui simule le délire paranoïaque. Ailleurs, les idées d'influence (sentiment d'être influencé par les autres depuis l'extérieur au niveau de la pensée et du comportement par un phénomène de télépathie) évoquent une bouffée délirante. Les délires de persécution ou d'influence sont moins caractéristiques d'une dépression mais leur apparition récente, parfois brusque, sans personnalité prédisposée, impose de suspecter une dépression et d'en rechercher les autres stigmates camouflés derrière le délire.

C) Certaines mélancolies revêtent l'allure de *confusion mentale* : les sujets paraissent obnubilés, perdus, désorientés dans le temps et dans l'espace, angoissés.

D) Un ralentissement intellectuel prononcé, sans tristesse exprimée, peut s'observer chez le sujet âgé évoquant une détérioration intellectuelle. C'est la *pseudo-démence dépressive*.

2. Les dépressions anxieuses. — L'anxiété fait partie du tableau de dépression à côté de la tristesse et du ralentissement. Sa prévalence peut masquer les autres éléments et infléchir le diagnostic vers la seule pathologie anxieuse.

L'anxiété prépondérante et les troubles fonctionnels multiples qui en découlent peuvent occulter le syndrome dépressif qui leur a donné naissance.

Il est important d'individualiser anxiété et dépression car les orientations thérapeutiques diffèrent. Certains symptômes sont plus évocateurs de dépression que d'anxiété :

- l'anorexie avec amaigrissement ;
- l'insomnie par réveil précoce ;
- le ralentissement psychomoteur ;
- l'accentuation matinale des troubles (inhibition et anxiété) ;
- le sentiment d'inappétence globale.

Anxiété et dépression sont deux concepts psychopathologiques qui s'enchevêtrent, se superposent et entretiennent de solides connivences.

La dépression fait sourdre l'anxiété et l'anxiété peut prédisposer à la dépression.

Un travail de P. Hardy, A. Féline et collaborateurs objective que la moitié des dépressions majeures s'accompagnent de crises d'angoisse aiguë (attaques de panique).

3. Dépression à forme hypocondriaque. — Troubles somatiques et plaintes hypocondriaques peuvent être au premier plan de la sémiologie dépressive qu'ils peuvent contribuer à masquer. Certains thèmes hypocondriaques délirants sont particulièrement évocateurs d'une mélancolie : certitude d'être atteint d'un cancer ou d'une maladie incurable, sentiment que le tube digestif ne fonctionne plus (« estomac bouché »), que les organes sont en état de décomposition ou qu'ils n'existent plus. Le délire de négation d'organe, dit délire de Cotard, est caractéristique d'une mélancolie délirante : le sujet a la certitude d'être déjà mort, la souffrance éprouvée devant survivre pour

l'éternité. Le risque suicidaire y serait moindre, la mort étant symboliquement réalisée dans l'imaginaire délirant. Le repérage de la dépression est plus difficile lorsque les troubles fonctionnels cénesthésiques sont prépondérants, exprimés avec conviction, en dehors de tout symptôme explicitement dépressif. Une multitude de troubles physiques mal systématisés, diffus et erratiques, de survenue récente, peut suggérer la dépression.

Par contre, un symptôme physique focalisé et fixe est peu évocateur de dépression.

Un homme de la cinquantaine, lors de ses accès dépressifs, rapportait exclusivement des céphalées et des nausées. De nombreux diagnostics somatiques furent suspectés tour à tour, vainement. La dépression fut envisagée au troisième accès lorsque l'interrogatoire minutieux mit en évidence quelques angoisses matinales et une plus grande fatigabilité intellectuelle que le sujet interprétait comme une conséquence logique de ses troubles physiques. La guérison par un traitement antidépresseur apportait, en quelque sorte, la preuve du diagnostic. Ces formes camouflées derrière un ou quelques symptômes trompeurs, en particulier physiques, définissent les « dépressions masquées », c'est-à-dire camouflées.

4. Les dépressions masquées. — Le concept de dépression masquée est né il y a une vingtaine d'années. Il désigne les formes où les symptômes dépressifs sont larvés et cachés derrière des signes trompeurs et imprécis.

La disparition de ces symptômes sous traitement antidépresseur est un argument en faveur de la dépression mais il n'est pas formel car les antidépresseurs ont d'autres activités thérapeutiques. Certains antidépresseurs sont actifs contre la douleur et peuvent, par exemple, guérir d'authentiques migraines. D'autres

molécules antidépessives sont efficaces contre l'anxiété ou la fatigue.

L'appartenance endogène ou psychogène des dépressions masquées n'est pas toujours évidente et il est probable qu'elles existent dans les deux catégories. Cependant, Kielholz, qui a introduit cette notion, la réservait aux dépressions endogènes « où la dysthymie dépressive est masquée, recouverte, par une symptomatologie somatique ».

Les dépressions masquées à symptômes somatiques sont les plus fréquentes. Parmi ceux-ci, les céphalées, les douleurs lombaires, les troubles digestifs, les palpitations, la gêne respiratoire, les douleurs génito-urinaires, les crampes et les sensations de fourmillements dans le corps (paresthésies) sont les plus habituels.

Certaines dépressions sont masquées derrière un signe isolé de la dépression mais peu spécifique : troubles du sommeil, de l'appétit ou de la sexualité.

Parfois, des troubles du caractère : impatiences, bouderies, irritabilité, émotivité excessive, agressivité, forment la partie émergée de l'iceberg dépressif. Les divers symptômes masquant la dépression ont deux caractéristiques :

- ils sont inhabituels et récents, comme greffés sur la personnalité habituelle ; en ce sens, ils évoquent un processus pathologique aigu, notamment dépressif ;
- ils s'accompagnent des perturbations minimales de la constellation dépressive, détectables à l'investigation minutieuse : angoisse du matin, fatigabilité intellectuelle, manque d'entrain, perte de l'enthousiasme.

5. Les équivalents dépressifs. — Les équivalents dépressifs sont des troubles isolés, rattachés à un processus dépressif par :

- l'absence d'une autre étiologie décelable ;
- leur apparition récente, marquant une rupture dans le mode de vie ;
- et la réponse favorable aux traitements antidépresseurs.

Ce sont des troubles somatiques, un alcoolisme ou une conduite toxicomaniaque, des manifestations névrotiques de tous les types (anxieux, phobique, hystérique, obsessionnel), divers syndromes douloureux, des perturbations isolées des conduites sexuelles, alimentaires ou du sommeil, des modifications du caractère, sans autre manifestation spécifique.

6. Les dépressions selon l'âge. — L'âge de survenue de la dépression induit des expressions cliniques préférentielles.

A) Chez l'enfant : les dépressions existent mais il convient d'éviter deux écueils :

- leur méconnaissance, car la verbalisation est réduite chez l'enfant et des manifestations comportementales ou caractérielles les expriment habituellement ;
- l'inflation du diagnostic, car le concept de dépression masquée est judicieusement répandu chez l'enfant, mais peut-être incite-t-il à évoquer la dépression devant des troubles d'une autre nature ? De plus, des moments dépressifs physiologiques sont habituels au cours du développement, notamment lorsque l'enfant intègre vers 7 à 8 ans le concept de mort dans son aspect inéluctable. Ces épisodes normaux de l'évolution doivent être différenciés de la maladie dépressive.

Le nourrisson soumis à une carence maternelle grave (disparition de la mère après une relation normale) présente un tableau évoquant une décompensation dépressive (dépression anaclitique). Initialement, pleurs, cris, opposition, troubles du sommeil et de l'alimentation constituent une véritable phase de protestation, précédant une période de passivité avec pauvreté de l'expression mimique et gestuelle, et même ralentissement du développement psychomoteur. Elle peut déboucher, en l'absence de la restauration de la relation maternelle, sur une organisation très vulnérable de la personnalité à l'âge adulte, susceptible de ruptures dépressives aux moindres frustrations.

Chez l'enfant, l'expression clinique est sous la dépendance du niveau de verbalisation. La tristesse douloureuse est peu formulée avant 8 ans.

À l'âge préscolaire, le changement de comportement avec pleurs, désintérêt au jeu, perturbations du sommeil, troubles sphinctériens et refus alimentaire peuvent traduire une dépression.

À l'âge scolaire, le tableau peut être plus net avec des manifestations anxieuses (terreurs nocturnes), un apragmatisme, un mutisme, une chute du rendement scolaire, parfois un refus de l'école. Mais l'expression peut être plus atténuée : tendance au retrait, réduction des contacts, désintérêt pour les activités scolaires ou de jeux et pleurs faciles.

L'apparition d'une énurésie (émission involontaire d'urine pendant le sommeil) et d'une encoprésie (perte involontaire des matières fécales) est assez évocatrice. Les tentatives de suicide sont exceptionnelles.

Misès met en exergue les syndromes dépressifs où domine l'isolement et parle de syndrome « inhibition-dépression ».

Golse et Messerschmitt présentent ainsi les symptômes dépressifs chez les enfants et les adolescents :

	<i>Symptômes psychiques</i>	<i>Symptômes somatiques</i>
Enfants en bas âge et d'âge préscolaire	Difficulté à jouer Agitation	Crises de larmes et de cris Encoprésie Insomnie Jactation Troubles de l'appétit
Enfants à l'âge scolaire	Irritabilité Manque d'assurance Difficultés à jouer Difficultés à apprendre	Enurésie Encoprésie Terreurs nocturnes Manipulations génitales excessives Crises de larmes et de cris
Préadolescents et adolescents	Ruminations Impulsions suicidaires Sentiment d'infériorité Abattement	Céphalées

D'après B. Golse et P. Messerschmitt, *L'enfant déprimé*, Paris, PUF, coll. « Nodules », 1983.

B) *Chez l'adolescent.* — La dépression n'est pas rare et sa prévalence se situerait vers 8 %, avec une prédominance féminine comme chez l'adulte.

a) *L'expression de la dépression chez l'adolescent* est assez proche de celle de l'adulte : ralentissement, angoisse, sentiment d'inefficacité, de dévalorisation sont verbalisés. Parfois, des symptômes moins évocateurs accompagnent les troubles dépressifs ou les masquent : troubles physiques divers, alimentaires (anorexie ou boulimie), du comportement comme les fugues, la délinquance ou le recours à l'alcool ou aux drogues. Leur manifestation récente tranchant avec le mode de vie habituel suggère un processus aigu. Les dépressions de l'adolescent peuvent se manifester après un événement

ou se situer sur un registre névrotique. Mais certaines psychoses maniaco-dépressives se révèlent à l'adolescence. Les idées et les tentatives de suicide sont fréquentes dans les dépressions de l'adolescent. Chabrol rapporte l'étude de Ryan et coll. où 34 % d'adolescents présentant une dépression majeure ont effectué une ou plusieurs tentatives de suicide : « Les idées et les tentatives de suicide étaient associées à la fois aux cognitions négatives de désespoir et de détresse et à l'impulsivité, à l'irritabilité et aux comportements antisociaux. »

b) *Le syndrome de morosité décrit par P. Male* n'est pas la maladie dépressive. Il constitue un état psychologique transitoire chez l'adolescent forcé d'abandonner les mirages de l'enfance et d'accepter les nécessités de l'âge adulte. Le syndrome de morosité est une réaction, presque physiologique, à la douloureuse mutation du principe de plaisir de l'enfant au principe de réalité de l'adulte.

L'adolescent éprouve désintérêt, ennui, difficultés à formuler des projets et à entreprendre des activités. Mais il n'est pas en proie à une tristesse douloureuse. Il peut envisager des plans pour l'avenir mais il manque d'entrain ou d'enthousiasme pour entreprendre leur réalisation. C'est en réalité une modalité existentielle de transition.

c) *La dépression atypique* n'est pas la dépression masquée. L'adjectif « atypique » concerne certains symptômes inhabituels à côté de la sémiologie dépressive et il renvoie surtout à l'éventualité d'une pathologie d'une autre nature qu'un trouble thymique. Qualifier une dépression d'« atypique » signifie que certains éléments cliniques évoquent la possibilité d'une évolution ultérieure vers une psychose schizophrénique.

Les dépressions atypiques s'observent essentiellement chez l'adolescent et l'adulte jeune. A côté des

signes dépressifs apparaissent des interrogations anxieuses sur l'intégrité corporelle (angoisse de dépersonnalisation), une certaine froideur affective, un détachement qui n'est pas un retrait douloureux mais plutôt une indifférence, des propos vagues et abstraits pour expliquer l'état (rationalisations) ; les thèmes développés n'apparaissent pas tous congruents à l'humeur dépressive, mais étranges, hermétiques, ne s'inscrivant pas dans l'optique du pessimisme ou de l'incapacité.

Toutes les dépressions atypiques ne débouchent pas inéluctablement sur une évolution schizophrénique mais elles incitent à une surveillance prolongée.

C) *Dépression de la cinquantaine.* — Chez la femme, la cinquantaine est marquée par la ménopause dont l'équivalence reste discutée chez l'homme. L'apparition vers cet âge d'une dépression chez un sujet indemne d'antécédents thymiques a été dénommée « dépression d'involution ». Elle revêt classiquement une allure mélancolique où prédominent anxiété ou douleur morale, plaintes hypocondriaques et thèmes de culpabilité. Les dépressions d'involution seraient d'évolution plus longue et volontiers résistantes aux traitements antidépresseurs. Par extension, certains auteurs dénomment abusivement dépression d'involution les dépressions symptomatiques qui marquent le début de la sénescence cérébrale et toutes les dépressions tardives.

D) *Le troisième âge.* — La dépression deviendrait plus fréquente chez les sujets âgés, vers 70 ou 80 ans. Cette notion est maintenant controversée. Les capacités intellectuelles, la richesse idéique, la production langagière, la vivacité et l'expressivité s'estompent de manière physiologique mais variable selon les sujets. Cette évolution explique probablement la sémiologie

particulière des dépressions des sujets âgés. Le ralentissement psychomoteur est souvent prononcé, prenant parfois l'allure d'une maladie de Parkinson (faciès figé, gestes lents, démarche à petits pas, voix monotone) ou d'une véritable prostration. Le désintérêt est souvent profond. Les plaintes hypocondriaques sont habituelles, relativement stéréotypées. La dépression « hypocondriaque » est fréquente chez le sujet âgé : la composante dépressive peut être masquée par les plaintes somatiques. Particulières sont de vagues idées de persécution, comme la crainte d'être volé, cambriolé, dénommées « idées de préjudice ». Celles-ci seraient un stigmate de détérioration intellectuelle, notamment de la maladie d'Alzheimer. Présentes dans les épisodes dépressifs, elles peuvent annoncer la démence débutante. Les dépressions tardives posent en effet le problème capital de leur rapport avec la détérioration, avec un continuum allant :

- des dépressions pseudo-démentielles, simulant la démence par la perte apparente des facultés intellectuelles mais guérissant complètement avec un traitement antidépresseur ;
- et les dépressions symptomatiques d'une détérioration où la régression du trouble thymique n'améliore pas la perte intellectuelle.

7. Dépressions et facteurs ethnoculturels. — La sémiologie des dépressions est issue des observations collectées dans les pays développés occidentaux. L'appartenance ethnique et les traditions socioculturelles impriment des originalités symptomatiques. La présentation du déprimé de Laponie n'est pas identique à celle du Sicilien mais des caractéristiques communes permettent d'établir la similitude diagnostique. Quel-

ques exemples illustrent les tableaux dépressifs trompeurs dans d'autres ethnies.

Le déprimé maghrébin exprime rarement une dévalorisation et/ou des thèmes d'auto-accusation ou d'incapacité. La dépression peut revêtir le masque de troubles somatiques et d'anxiété, ou l'aspect d'un état délirant dont les thèmes de persécution suggèrent peu le dérèglement thymique.

Parfois, l'apparence est celle d'une bouffée délirante avec hallucinations auditives, syndrome d'influence (sentiment que les pensées et les actes sont imposés par une force extérieure occulte), thèmes délirants variés où la persécution domine sans être exclusive. L'enquête anamnétique, les antécédents, quelques signes dépressifs d'accompagnement permettent d'éviter l'erreur diagnostique car le traitement d'une bouffée délirante est différent de celui d'une dépression.

Dans les dépressions d'Afrique noire, les symptômes sont tout aussi différents : la tristesse, la perte des intérêts et du plaisir et la dévalorisation sont peu explicitées.

Typiquement, ces dépressions comportent irritabilité, sentiment d'ennui, idées de persécution avec thèmes d'ensorcellement, de possession, de magie, fatigue et ralentissement. L'insomnie est rarement repérée par le sujet ou son entourage.

Les plaintes somatiques occultent souvent les symptômes dépressifs.

Mais il existe d'autres « masques » de la dépression qui sont :

- les manifestations d'allure hystérique = masques névrotiques ;
- les épisodes d'agitation avec agressivité, ou des tableaux de stupeur psychique et motrice = masques comportementaux ;

Tableau comparatif des dépressions

	<i>Clinique française</i>	<i>Clinique africaine</i>
A. Troubles de l'humeur		
Tristesse pathologique	oui	parfois
Douleur morale	oui	parfois
Irritabilité	oui	oui
Sentiment d'ennui	oui	oui
Anhédonie	oui	peu exprimée par les malades
Perte des intérêts	oui	parfois
B. Troubles des contenus de la pensée		
Dévalorisation (sentiment d'infériorité, d'incapacité)	oui	exceptionnel
Culpabilité avec auto-accusation	oui	rare
Se plaint d'incompréhension	oui	non
Persécution	rare	oui + + +
Pessimisme, sentiment d'incurabilité	oui	rare
Symptôme hallucinatoire	non	oui + + +
C. Inhibition psychomotrice		
Fatigue intense	oui	oui
Ralentissement moteur	oui	oui
Lenteur du débit verbal	oui	parfois
Lenteur des mouvements	oui	parfois
Ralentissement psychique (troubles d'attention, de la mémoire)	oui	peu évident
D. Troubles physiques		
Insomnie	oui	oui
Réveil précoce	oui	oui
Anorexie	oui	plus ou moins intense
Diminution de la libido (troubles sexuels)	oui	peu évident
Bouche sèche, colique	parfois	oui
Constipation, hypotension	parfois	parfois
Maux de tête	parfois	oui
Vertiges	parfois	parfois
Polyalgies chroniques	parfois	oui + + +
Oppression thoracique	parfois	oui

D'après B. D. Damba, Les dépressions en France et en Afrique noire, *Les Carnets de la Psychiatrie*, Paris, Euthérapie (éd.), 1988, 6.

- les symptômes de bouffée délirante aiguë ou de schizophrénie par la présence de syndrome d'influence, d'hallucinations, de thèmes délirants peu structurés = masques psychotiques ;
- le syndrome confusionnel avec hébétude, perplexité anxieuse, désorientation dans le temps et l'espace, ralentissement psychique global = masque organique.

Pour rendre compte des similitudes et des différences entre les dépressions en France et en Afrique noire francophone, certains auteurs décrivent « les masques blancs » et « les masques noirs » de la dépression. B. D. Damba a établi cette comparaison.

L'importance de l'immigration africaine en France exige de repérer les dépressions malgré les distorsions sémiologiques ; en effet des dépressions sont parfois liées à la transplantation, à l'isolement affectif et aux contraintes matérielles.

IV. — Le suicide dans les dépressions

Le suicide confère la gravité aux syndromes dépressifs. C'est le risque léthal essentiel. Mais suicide ou tentative de suicide ne sont pas synonymes de dépression. D'après les travaux de Avery et Winokur, rapportés par Rouillon, 45 à 70 % des tentatives de suicide seraient attribuables à une dépression : 15 % des déprimés se suicideraient et 10 % des tentatives sont suivies d'un suicide réussi dans les dix années suivantes. Rouillon écrit : « La prévalence du suicide en un an, chez des patients déprimés non traités, est de 1,5 à 5 % selon les auteurs, soit 100 à 500 fois plus que le taux annuel de la population générale. » Tentatives de suicide et suicides sont plus nombreux à l'adolescence et à l'âge avancé. Mais le taux de mortalité par suicide est plus élevé chez le sujet âgé.

Le type de la dépression, le sexe du déprimé et l'âge induiraient les modalités de suicide. L'intoxication médicamenteuse est la méthode la plus employée. Classiquement, le désir ambivalent de suicide d'une dépression névrotique aurait plus volontiers recours à l'absorption médicamenteuse alors que la prégnance des propensions suicidaires mélancoliques inciterait à des moyens plus radicaux : pendaison, noyade, arme à feu. Mais le schéma est réducteur et d'autres facteurs entrent en ligne de compte. Ainsi, le déprimé à la campagne se pend ou se noie alors que le citadin recourt à l'intoxication par le gaz. Les moyens à disposition entrent en ligne de compte.

Certains actes sont impulsifs, en réponse à un événement même mineur. Le déprimé névrotique, réactif aux conditions environnementales, peut recourir aux formes les plus violentes lors d'un paroxysme anxieux.

Le taux de suicide dépressif est plus élevé chez les sujets isolés, vivant dans des conditions matérielles précaires.

Certains symptômes dépressifs indiqueraient un risque élevé : anxiété, agitation, réveil précoce. Toute formulation d'idées de suicide par le déprimé doit être sérieusement prise en considération, quel que soit le registre nosographique où elle s'inscrit. Certains auteurs ont cru déceler un syndrome présuicidaire, avec repli sur soi et disparition apparente de l'agressivité.

En réalité, le suicide est souvent imprévisible dans les dépressions mais le risque est permanent.

Chapitre III

CLASSIFICATIONS ET ÉVALUATION DES DÉPRESSIONS

La traditionnelle distinction des dépressions : psychotique-endogène, névrotique-exogène, réactionnelle, symptomatique, exprime diverses particularités cliniques mais pas toutes. C'est le caractère contingent des définitions et leurs inévitables lacunes.

Diverses études, pour répondre à la diversité des cas, ont élargi, multiplié les cadres, défini des critères diagnostiques plus affinés et même proposé des échelles d'évaluation afin de quantifier la perturbation psychique.

Organismes officiels, personnalités notoires, mêlant égarement et savoir, ont créé un nouveau look de la psychiatrie dont le DSM 3 révisé est la plus voyante parure.

Ces critères, classifications et échelles, enrichis de sève américaine, destituent ceux d'hier devenus caducs. Mais que dira-t-on de ceux d'aujourd'hui, demain ?

Cependant, la démarche des « rénovateurs » dans ses perspectives, ses intentions, ne manque ni d'intérêt, ni d'ambition : répondre à la diversité des cas cliniques, établir une sorte de standardisation avec consensus international sur la terminologie, les classifications diagnostiques et peut-être le traitement.

De plus, un souci d'efficiencce, peut-être aussi de démystification : au lieu d'une longue et minutieuse description, appréhender plus vite, sinon mieux, par des instruments et des techniques performants, le paysage psychologique comme un instantané photographique globalisant.

Une technique exigeant une passivité appliquée, sans aptitude, ni formation particulières !

Des systèmes conventionnels admis de tous, s'adaptant à tout ! Mais leur diversité témoigne d'une unanimité incertaine.

Les plus connus seront évoqués dans leur esprit. Un exposé complet des critères, des échelles et de leurs items pour les dépressions est une entreprise fastidieuse et sans limite.

I. — Les classifications officielles des dépressions

Deux classifications officielles des dépressions maintiennent la distinction entre dépression psychotique et dépression névrotique.

1. La classification de l'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale en France (INSERM) présente 20 catégories diagnostiques de troubles mentaux parmi lesquels figurent les dépressions dans plusieurs rubriques :

- les psychoses maniaques et dépressives ;
- les schizophrénies chroniques comportent une sous-catégorie : « schizophrénie chronique avec troubles thymiques. Etats de dépression et d'excitation atypique » ;
- les dépressions symptomatiques révélant ou accompagnant une maladie physique ;

- la personnalité dépressive dans la rubrique « Personnalité et caractères pathologiques » ;
- « les états dépressifs non psychotiques » avec :
 - état dépressif de type névrotique. Dépression névrotique,
 - dépressions réactionnelles non psychotiques.

La classification de l'INSERM rend assez bien compte des diverses dépressions. Mais les catégories isolées ne comportent pas de critères de définition. Il n'existe aucun repère pour guider la décision qui repose exclusivement sur l'expérience du médecin et ses *a priori* théoriques.

2. La classification de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans la neuvième révision de la Classification internationale des Maladies (CIM9 de l'OMS) s'accompagne d'un glossaire explicatif. Les catégories dans lesquelles sont mentionnés les états dépressifs sont les suivantes :

296. « Psychoses affectives » qui comportent plusieurs rubriques :
- 296.0. Psychose maniaque dépressive — forme maniaque.
 - 296.1. Psychose maniaque dépressive — forme dépressive.
 - 296.2. Psychose maniaque dépressive — forme circulaire en période maniaque.
 - 296.3. Psychose maniaque dépressive — forme circulaire en période dépressive.
 - 296.4. Psychose maniaque dépressive — forme circulaire mixte, etc.

La CIM 9 individualise donc les aspects évolutifs de la psychose maniaco-dépressive. Elle sépare les formes unipolaires (296.0 et 296.1) et bipolaires (formes circulaires).

Les autres catégories d'états dépressifs sont :

- « Autres psychoses non organiques » : « Forme dépressive ».

La CIM 9 reconnaît l'existence de dépression psychotique en dehors de la PMD :

- « Troubles névrotiques » avec un chapitre : « Dépression névrotique » ;
- « Troubles de la personnalité », avec « Personnalité dysthymique (affective) », qui semble correspondre à la personnalité dépressive ;
- dans les « états réactionnels aigus à une situation très éprouvante » se situe d'abord une rubrique : « avec troubles prédominants de l'affectivité ». Cette sous-catégorie évoque les dépressions réactionnelles ;
- dans la catégorie « Troubles de l'adaptation », les deux premières subdivisions sont :
 - réaction dépressive brève,
 - réaction dépressive prolongée ;
- une catégorie envisage les « Troubles de l'affectivité spécifique de l'enfance et de l'adolescence ».

Ainsi, la CIM 9 maintient la distinction entre les dépressions, psychotique, névrotique et réactionnelle. Dans l'optique classique, elle oppose les psychoses affectives ou PMD au champ protéiforme des dépressions psychogènes.

Elle ignore par contre les états dépressifs symptomatiques.

Une nouvelle classification de l'OMS, la CIM 10, est en préparation.

II. — Les catégories de la psychose maniaco-dépressive

Des formes intermédiaires hybrides suggèrent une éventuelle unicité des dépressions, de gravité croissante du pôle psychogène au pôle endogène. Cependant, des auteurs affirment la distinction qualitative entre les deux entités, malgré quelques similitudes et certains chevauchements. La dépression endogène est souvent l'expression de la PMD. Celle-ci, initialement considérée bien délimitée, tend à être subdivisée en catégories à cause des aspects évolutifs, des antécédents familiaux et des réponses thérapeutiques inégales au même traitement.

1. Formes unipolaire et bipolaire de la PMD. — Accès dépressifs et épisodes d'excitation euphorique, séparés par un intervalle libre, constituent la forme bipolaire. La forme unipolaire est définie par la survenue répétitive d'un seul type d'accès en règle dépressif.

L'alternance de ces états est variable dans leur enchaînement et leur fréquence. Particulièrement exemplaire est la succession régulière d'une dépression et d'une manie séparées par un intervalle libre. Mais certains sujets présentent plusieurs accès dépressifs pour un épisode maniaque ou inversement. Leur fréquence est régulière chez les uns, irrégulière chez d'autres. La PMD a des aspects très diversifiés. Une malade a présenté le premier accès maniaque après une vingtaine d'accès dépressifs en trente ans d'évolution. Initialement considérée comme unipolaire, elle était en réalité une bipolaire. Ainsi, les jugements portés et les analyses sont aventureux.

Comment distinguer une forme monopolaire au début d'une forme bipolaire dont l'autre manifestation apparaîtra très à distance dans le temps ? Pour Bourgeois et coll., sous l'effet du traitement antidépres-

seur, 9 % des dépressions unipolaires deviennent bipolaires.

Certaines ruptures dysthymiques endogènes semblent conditionnées par l'événement, la conjoncture, les variations saisonnières, autant que par le déterminisme génétique.

Dans le cadre des dépressions endogènes, Rosenthal et coll. ont isolé les dépressions saisonnières qui apparaissent à l'automne ; certaines s'accompagnent d'une manie plus ou moins intense au printemps. Quelques auteurs maintiennent la ségrégation et considèrent les formes unipolaire et bipolaire comme étant de nature différente d'après certaines caractéristiques :

- antécédents familiaux thymiques plus fréquents dans les bipolaires ;
- sémiologie inhibée dans les dépressions bipolaires, plus volontiers anxieuse et agitée, dans les monopolaires ;
- début précoce pour les bipolaires (avant 30 ans), entre 30 et 50 pour les monopolaires ;
- le lithium est plus efficace dans la prévention des rechutes bipolaires que dans celle des formes monopolaires ;
- en période de normalité les bipolaires sont mieux adaptés, les monopolaires présentent des traits névrotiques anxieux.

Les formes unipolaires maniaques demeurent rares.

2. Fréquence et durée des accès dans la PMD. — La fréquence des accès est très variable, d'un épisode unique sur plusieurs années à plusieurs dans la même.

L'existence ou non d'intervalles libres, la fréquence et la durée des accès participent aussi à l'aspect de la maladie. Ainsi se distinguent les accès séparés par des

intervalles libres : forme intermittente, et les accès se succédant sans intermittence : forme rémittente.

Certaines affections sont à périodes courtes (un jour à un mois) sans intervalle libre, d'autres à périodes longues avec intervalles libres.

3. PMD à cycles rapides. — En 1974, Dunner et Fieve différencient deux sous-groupes de formes bipolaires : celles ayant au moins quatre épisodes par an appelées formes à « cycles rapides », et celles dont la fréquence est inférieure.

Ces deux sous-groupes ne présentent pas la même réponse aux traitements préventifs. Les cycles rapides sont plutôt résistants au lithium.

III. — Critères diagnostiques modernes des dépressions

Les classifications officielles des dépressions reposent sur des données cliniques, évolutives et étiopathogéniques. La dichotomie endogène-psychogène fait essentiellement référence à un facteur causal primordial.

Cet abord multifactoriel des classifications où s'enchêâtrent les éléments cliniques (aspect des dépressions) et des références théoriques (endogène ou psychogène) explique la difficulté à catégoriser de nombreuses dépressions.

Des systèmes de critères diagnostiques exclusivement descriptifs et précis ont paru plus adaptés pour désigner les types de dépression et les différencier entre elles. Cette approche concrète réfute toute connotation théorique. C'est l'ensemble des signes de la dépression présents à un moment donné qui définit l'appartenance à une catégorie. Chacune comporte des critères d'inclusion et d'exclusion. Les dépressions ainsi définies renvoient à des tableaux cliniques assez bien circonscrits. Plusieurs classifications modernes se sont

inspirées de cette conception mais deux méritent d'être mises en exergue.

1. La classification de l'école Saint-Louis. — Elle sépare les dépressions en deux catégories antinomiques. Aucune dépression ne peut se situer en position intermédiaire. Elle oppose :

- les *dépressions primaires* où le sujet ne présente aucun antécédent de trouble psychique (hormis des antécédents de trouble de l'humeur) et aucune maladie physique concomitante ;
- aux *dépressions secondaires* survenant chez un sujet ayant des antécédents de troubles psychiques (alcoolisme, névrose, psychoses non thymiques) ou une affection somatique simultanée.

Le critère de classification se situe dans les antécédents et ne fait pas référence aux autres distinctions nosographiques. Pichot, Guelfi et Pull remarquent judicieusement que « la distinction primaire-secondaire est complètement indépendante de toutes les autres dichotomies (une dépression "névrotique" peut parfaitement être une dépression primaire, mais la dépression au cours d'une psychose maniaco-dépressive bipolaire typique chez un alcoolique est une dépression secondaire) ».

2. Le « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » ou DSM 3. — Le DSM 3 et sa version révisée, rédigés par l'Association américaine de Psychiatrie (APA), constituent actuellement le système diagnostique le plus utilisé.

● *Principe*

La classification des troubles mentaux s'effectue selon cinq axes.

L'axe I rapporte les symptômes des différents troubles mentaux : tous les diagnostics y figurent.

L'axe II envisage les désordres de la personnalité et les troubles du développement.

L'axe III regroupe les maladies somatiques pouvant se manifester en même temps que le trouble mental.

L'axe IV énumère les divers stress psychosociaux qui peuvent être concomitants du trouble mental.

L'axe V apprécie le niveau maximum d'adaptation psychosociale dans l'année précédant la cotation.

Une dépression sera diagnostiquée selon l'axe I. Si elle survient sur une personnalité pathologique, elle sera cotée sur les axes I et II. S'il existe une maladie organique ou un stress psychosocial, la dépression sera également cotée sur l'axe III ou IV.

La lecture des critères diagnostiques des catégories de dépression selon le DSM 3 permet de se familiariser avec ses multiples expressions formulées de manière pratique, concrète. La clarté de l'énoncé des critères évite l'écueil de l'ambiguïté et permet de situer les dépressions dans un cadre déterminé. L'objectif du DSM 3 n'est pas d'établir une classification des dépressions sur des concepts théoriques (endogène/psychogène) mais de décrire des malades. La classification du DSM 3 repose essentiellement sur la nature, l'intensité et la durée des symptômes. Trois catégories principales de troubles affectifs sont individualisées dans l'axe I du DSM 3 :

a) *Les troubles affectifs majeurs* comprenant :

- l'accès maniaque ;
- l'épisode dépressif majeur qui peut être : isolé, récurrent, ou s'intégrer dans le trouble bipolaire s'il existe un ou plusieurs épisodes maniaques.

b) *Les autres troubles affectifs spécifiques* sont définis par un syndrome affectif incomplet et une durée du trouble de l'humeur de plus de deux ans de façon permanente ou intermittente. Ils sont de deux types :

— *Le trouble cyclothymique* est un trouble de l'humeur, permanent depuis plus de deux ans, comprenant des périodes dépressives et hypomaniaques qui n'ont pas l'intensité pour répondre aux critères d'épisode dépressif majeur ou de manie.

Il peut exister des périodes d'humeur normale entre les épisodes. Ce trouble correspond à la classique personnalité cyclothymique.

— *Le trouble dysthymique*, aussi appelé « névrose dépressive », est caractérisé par un trouble dépressif chronique de l'humeur dont la sévérité est insuffisante pour constituer un épisode dépressif majeur avec lequel il partage certains symptômes, mais atténués ; le trouble dysthymique correspond aux personnalités dépressives.

c) *Les troubles affectifs atypiques* regroupent tous les troubles de l'humeur (bipolaire, au cours d'une schizophrénie, dépressif bref) qui ne peuvent être rangés dans les catégories précédentes.

● *Critères diagnostiques d'un épisode dépressif majeur*

Ces critères rassemblent l'essentiel de la sémiologie des dépressions caractérisées. L'adjectif « majeur » signifie que l'épisode dépressif est patent. Les critères sont :

a) Humeur dysphorique ou perte d'intérêt ou de plaisir pour toutes ou presque toutes les activités usuelles et les passe-temps. L'humeur dysphorique est caractérisée par des symptômes particuliers : déprimé, triste, cafardeux, sans espoir, au bout du rouleau, irritable. Le trouble de l'humeur doit être évident et relativement persistant, mais n'est pas forcément le symptôme prédominant ; il n'inclut pas les changements soudains d'une humeur dysphorique à une autre humeur dysphorique, par exemple le passage de l'anxiété à la dépression et à la colère, tels qu'on les observe dans les états de perturbation psychotique aiguë.

b) Au moins quatre symptômes doivent chacun avoir été présents presque tous les jours pendant une période d'au moins deux semaines (pour les enfants de moins de 6 ans, au moins

trois des quatre premiers), parmi une liste de huit où figurent l'anorexie ou perte significative de poids ou l'augmentation de l'appétit ou prise significative de poids, les troubles du sommeil, la perte d'intérêt ou de plaisir, la perte d'énergie et la fatigue, etc.

Plusieurs sous-catégories de l'épisode dépressif majeur sont définies en fonction de la gravité :

- *en rémission* lorsque les symptômes ont disparu, ou ne sont plus suffisants pour porter le diagnostic d'épisode dépressif majeur ;
- *sans mélancolie* ;
- *avec mélancolie* définie par des caractéristiques sémiologiques précises comme la perte de plaisir et la présence des signes dits biologiques de la dépression : anorexie, perte de poids, réveil matinal précoce ;
- *avec caractéristiques psychotiques* lorsqu'il existe une altération de la perception de la réalité, des idées délirantes et/ou des hallucinations qui peuvent être congruentes à l'humeur (thèmes de culpabilité, de mort, de punition méritée...) ou non congruente (thèmes de persécution, d'influence extérieure).

Les critères de l'épisode dépressif majeur et des sous-catégories permettent d'obtenir des groupes de malades sémiologiquement assez homogènes.

● *Critères diagnostiques d'un trouble cyclothymique*

a) Durant les deux dernières années, nombreuses périodes au cours desquelles quelques symptômes caractéristiques à la fois de syndromes dépressifs et maniaques ont été présents, mais dont la sévérité et la durée ne sont pas suffisantes pour répondre aux critères d'un épisode dépressif ou maniaque majeur.

b) Les périodes dépressives et hypomaniaques peuvent être séparées par des périodes normothymiques pouvant persister plusieurs mois de suite ; elles peuvent s'intriquer ou alterner.

c) Puis sont mentionnés les différents symptômes qui définissent soit les périodes dépressives, soit les périodes hypomaniaques.

3. Autres critères diagnostiques. — De nombreux auteurs ont proposé différents systèmes de critères dia-

gnostiques pour les dépressions selon diverses approches théoriques ou cliniques.

La « liste intégrée des critères d'évaluation taxinomique pour la dépression (LICET-D) » prend en considération plusieurs systèmes de critères diagnostiques. C'est en quelque sorte une approche polydiagnostique. Elle est rigoureuse, lourde dans sa réalisation et réservée aux travaux de recherche.

IV. — Echelles d'évaluation de la dépression

De nombreux questionnaires ou listes de symptômes à remplir par le malade et des échelles d'appréciation de la sémilogie à établir par le médecin ont plusieurs objectifs :

- quantifier la dépression, c'est-à-dire en estimer la sévérité ;
- suivre l'évolution sous traitement ;
- évaluer l'importance des principaux symptômes (anxiété, ralentissement, troubles physiques, idées suicidaires) dans la gravité générale, conditionnant pour une part le choix thérapeutique.

L'utilisation de tels instruments apporte la rigueur pour apprécier l'efficacité des traitements.

1. Autoquestionnaires de la symptomatologie dépressive. — Le principe est de demander au malade, par l'intermédiaire de phrases ou d'adjectifs décrivant divers états psychiques anormaux, d'intensité croissante, de dépeindre son état actuel.

Dans l'échelle d'auto-appréciation de la dépression de Zung, le malade répond à 20 propositions concernant son état par les réponses : pas du tout, exceptionnellement, parfois, souvent, ou le plus souvent.

Le questionnaire QD2 de P. Pichot illustre ce type de questionnaire :

En ce moment, ma vie me semble vide	Vrai ☐	Faux ☐
J'ai du mal à me débarrasser de mauvaises pensées qui me passent par la tête	Vrai ☐	Faux ☐
Je suis sans énergie	Vrai ☐	Faux ☐
Je me sens bloqué(e) ou empêché(e) devant la moindre chose	Vrai ☐	Faux ☐
Je suis déçu(e) et dégoûté(e) par moi-même	Vrai ☐	Faux ☐
Je suis obligé(e) de me forcer pour faire quoi que ce soit	Vrai ☐	Faux ☐
J'ai du mal à faire les choses que j'avais l'habitude de faire	Vrai ☐	Faux ☐
En ce moment, je suis triste	Vrai ☐	Faux ☐
J'ai l'esprit moins clair que d'habitude	Vrai ☐	Faux ☐
J'aime moins qu'avant les choses qui me plaisent ou m'intéressent	Vrai ☐	Faux ☐
Ma mémoire me semble moins bonne que d'habitude	Vrai ☐	Faux ☐
Je suis sans espoir pour l'avenir	Vrai ☐	Faux ☐
En ce moment, je me sens moins heureux(se) que la plupart des gens	Vrai ☐	Faux ☐

Le malade remplit lui-même le questionnaire. Chaque réponse « vrai » vaut un point. La note totale constituée par le nombre de réponses « vrai » varie de 0 à 13. « Toute note égale ou supérieure à 7 affirme l'existence d'une symptomatologie dépressive cliniquement significative. »

2. Echelles d'appréciation de la dépression. — Ces instruments d'évaluation sont remplis par le médecin au cours d'un entretien qui doit aborder tous les items contenus dans l'échelle.

— *L'échelle de dépression de Hamilton* est la plus connue. Il en existe plusieurs versions. La version de 1967 comporte 25 items cotés de 1 à 3 ou de 1 à 5.

Les items sont : humeur dépressive, sentiments de culpabilité, suicide, insomnie du début de la nuit, insomnie du milieu de la nuit, insomnie du matin, travail et activités, ralentissement, agitation, anxiété psychique, anxiété somatique, symptômes

somatiques généraux, symptômes génitaux, hypocondrie, perte de poids selon les dires du malade, perte de poids appréciée par pesée, prise de conscience, variations de la symptomatologie dans la journée, dépersonnalisation et déréalisation, symptômes délirants (persécutifs), symptômes obsessionnels et compulsionnels, sentiments d'impuissance, sentiment d'être sans espoir, sentiment de dévalorisation.

Chaque degré à l'intérieur d'un item est précisé par une phrase ou quelques mots.

A titre d'exemple, le premier item sur « humeur dépressive » est ainsi présenté :

Tristesse, sentiment d'être sans espoir, impuissant, autodépréciation :

- Absent.
- Ces états affectifs ne sont signalés que si l'on interroge le sujet.
- Ces états affectifs sont signalés verbalement spontanément.
- Le sujet communique ces états affectifs non verbalement
 - par ex. par son expression faciale, son attitude, sa voix et sa tendance à pleurer.
- Le sujet ne communique pratiquement que ces états affectifs dans ses communications spontanées verbales et non verbales.

— *L'échelle de Montgomery et Asberg (MADRS)* est la plus employée. Elle comprend 10 items et 6 degrés d'intensité croissante avec des points définis (0, 2, 4, 6) et des points intermédiaires sans définition. Chaque item comporte une description succincte. A titre d'exemple l'item 1 est ainsi présenté :

1. Tristesse apparente.

Correspond au découragement, à la dépression et au désespoir (plus qu'au simple cafard passager) reflétés par la parole, la mimique et la posture. Coter selon la profondeur et l'incapacité à se dérider :

- 0 Pas de tristesse.
- 1
- 2 Semble découragé mais peut se dérider sans difficulté.
- 3
- 4 Paraît triste et malheureux la plupart du temps.
- 5
- 6 Semble malheureux tout le temps. Extrêmement découragé.

Les autres items de l'échelle MADRS sont :

- 2 Tristesse exprimée.
- 3 Tension intérieure.
- 4 Réduction de sommeil.
- 5 Réduction de l'appétit.
- 6 Difficultés de concentration.
- 7 Lassitude.
- 8 Incapacité à ressentir.
- 9 Pensées pessimistes.
- 10 Idées de suicide.

Pour les échelles de quantification, il n'est pas défini une note absolue au-dessus de laquelle on peut affirmer la dépression ou au-dessous de laquelle elle doit être récusée.

Les échelles sont utilisées dans les essais thérapeutiques pour fixer un minimum de gravité pour inclure le malade dans l'étude. Elles servent à suivre l'évolution de manière objective quantifiée. Elles ne fondent jamais le diagnostic de dépression qui revient à l'observation clinique et à l'utilisation des critères diagnostiques.

Les diverses classifications, l'emploi de plus en plus extensif de critères diagnostiques et d'échelles d'évaluation ne permettent pas d'éclairer le débat sur le concept catégoriel ou unitaire de la dépression.

Chapitre IV

QUI LA DÉPRESSION TOUCHE-T-ELLE ? OU DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

L'épidémiologie étudie l'importance, la répartition, les particularités de survenue de la maladie dépressive.

Ce repérage dégage les facteurs de risque pour adapter les mesures de prévention.

I. — Quelques notions en épidémiologie

L'épidémiologie descriptive utilise les indices capables de situer l'importance quantitative d'une maladie.

1. Mortalité et morbidité. — La mortalité désigne la fréquence, en pourcentage, pendant un certain temps, des décès dus à une maladie. Les morts dans la dépression sont souvent liées aux suicides réussis : « mortalité suicidaire ». Mais il existe aussi dans la dépression une mortalité non attribuable au suicide.

La morbidité est l'ensemble des données qui reflètent la fréquence de la maladie dans la population selon des approches diverses où deux indices sont essentiels : l'incidence et la prévalence.

2. Incidence et prévalence. — L'incidence est la fréquence des nouveaux cas pour une maladie, pendant une période donnée (souvent une année), au sein d'une population.

La prévalence est le pourcentage de cas de maladies par rapport à une population (générale ou particulière : consultants, région) :

- à un moment donné : prévalence ponctuelle ;
- sur une durée de temps définie : six mois ou un an ;
- sur toute la vie : la prévalence alors est la proportion de tous les sujets qui, à un moment donné, sont malades et ceux qui l'ont été par le passé. Les deux éléments sont additionnés et rapportés à la population étudiée.

Les études épidémiologiques sur la dépression envisagent essentiellement la prévalence.

3. Difficultés des approches épidémiologiques de la dépression. — La principale difficulté est la définition de la dépression car les critères de diagnostic sont multiples et les résultats ne sont pas toujours homogènes. Probablement, certaines techniques méthodologiques tendent à majorer la morbidité dépressive et d'autres la minorent. Cependant, les critères modernes, dont ceux du DSM 3, donnent des chiffres moins hétérogènes.

La population de référence doit être la population générale parmi laquelle il faut détecter les dépressions par des enquêtes systématiques. L'épidémiologie ne doit pas se contenter de comptabiliser seulement les déprimés qui consultent ; ils sont un faible pourcentage, en comparaison des sujets atteints par la maladie sans recours médical.

II. — Données sur la morbidité dépressive

F. Rouillon, Bertschy et coll. ont effectué deux excellentes synthèses des principales études épidémiologiques sur la dépression, notamment à partir des travaux de Weissman et Myers et de l'équipe de Robins. Elles

mettent en évidence l'importance de la maladie dépressive.

1. Prévalence ponctuelle. — Elle est de 6,8 % dans la population générale d'après Weisman et Myers et se répartit ainsi :

- 4,3 % dépression majeure ;
- 2,5 % dépression mineure.

Le concept de dépression mineure est flou et plusieurs auteurs envisagent essentiellement les dépressions majeures.

Les travaux rapportés par Bertschy et coll. situent la prévalence ponctuelle de dépression majeure entre 3,8 % et 4 %.

La prévalence ponctuelle de dépression majeure est plus importante chez la femme (5,2 à 6,9 %) que chez l'homme (2,6 à 3,6 %).

2. Prévalence sur six mois ou un an. — Dans la synthèse de Bertschy et coll., les chiffres varient :

- sur six mois entre : 2 % et 3,7 % ;
- sur un an entre : 3 et 3,7 %.

Les résultats confirment le taux considérablement élevé chez la femme puisque des chiffres de 11 à 17,6 % de prévalence sur un an sont mentionnés.

3. Prévalence sur la vie. — Elle est de 26,7 % d'après Weisman et Myers dont 20 % pour la dépression majeure. Une enquête menée à Los Angeles trouve une prévalence des dépressions majeures de 8,4 % sur la vie.

Ces études objectivent la prépondérance féminine, les pourcentages étant dans l'ensemble double de celui des hommes.

Le travail de Robins sur l'ensemble des troubles psychiatriques au cours de toute la vie situe les troubles

thymiques en troisième position derrière l'alcoolisme et les toxicomanies (15 à 18 %) et les troubles névrotiques et anxieux (11 %).

La prévalence du trouble bipolaire est d'environ 1 %. Le risque dépressif est bien objectivé par les études de prévalence : 3 à 6 % des hommes et 5 à 10 % des femmes ont une dépression caractérisée ou l'ont présentée durant leur vie.

4. Morbidité et âge. — Des travaux tendent à démontrer que, contrairement à l'opinion habituelle, la prévalence de la dépression majeure est plus marquée dans les tranches d'âge les plus jeunes et tend à décroître vers les tranches d'âge plus avancées. Dans l'étude de Karno et coll., la prévalence de la dépression est plus élevée chez les moins de 40 ans que chez les plus de 40 ans.

III. — Données épidémiologiques sur la mortalité

Tous les suicides ne renvoient pas à la maladie dépressive mais plus de la moitié en seraient la conséquence. 10 à 20 % de l'ensemble des déprimés meurent par suicide et d'après les travaux répertoriés par Bertschy et coll. : « Chaque année, 3 à 5 % des sujets atteints de troubles affectifs se suicident. »

10 % des sujets ayant effectué une tentative de suicide mourront de suicide dans les dix ans qui suivent (travaux de Avery et Winokur en 1978). Mais, en dehors du suicide, il semble exister une surmortalité chez les sujets déprimés ou l'ayant été. Murphy et coll., en 1987, suivent des déprimés au long cours : la surmortalité est estimée à 60 % et concerne surtout les hommes.

Des recherches sont indispensables pour expliquer ce phénomène : les liens entre système nerveux central et système de défense immunitaire entrouvrent des perspectives.

IV. — Le risque morbide

Le risque morbide dépressif est le pourcentage de sujets parmi la population générale susceptibles de présenter une dépression à un moment de leur vie, en partant du postulat qu'ils survivent tous assez longtemps pour être confrontés aux différentes périodes à risques. Le risque morbide est donc une notion abstraite. Par contre, la prévalence de la dépression sur toute la vie est une mesure réelle effectuée à partir d'études rétrospectives. Mais celles-ci risquent de minimiser le phénomène en méconnaissant des dépressions anciennes. De plus, elles ne comptabilisent pas les sujets disparus avant d'avoir pu éventuellement présenter une rupture dépressive.

Ainsi, le risque morbide est plus élevé que la prévalence sur toute la vie. Il se situerait entre 9 et 15 % avec le rapport de deux femmes pour un homme. Pour Bertschy et coll. : « Le risque morbide sur la vie entière de trouble affectif majeur serait actuellement 6 à 10 % chez l'homme et de 12 à 20 % chez la femme. »

Derrière l'aridité des chiffres issus de l'épidémiologie descriptive, se manifeste clairement l'importance de la maladie dépressive en médecine. Celle-ci est encore authentifiée par des enquêtes où 10 à 20 % des consultants de médecine générale sont des déprimés dont la moitié rechutera une ou plusieurs fois.

V. — Caractéristiques socio-démographiques des déprimés

L'étude des caractéristiques démographiques, sociales et existentielles des déprimés permet de détecter des facteurs prédisposants dénommés facteurs de risque. C'est l'épidémiologie analytique dont l'objectif est

d'élaborer des hypothèses étiopathogéniques, à partir des circonstances de survenue.

1. Sexe et statut marital. — Pour expliquer la prévalence de la dépression, deux fois plus fréquente chez la femme, d'après l'étude d'Amenson et Lewinsohn rapportée par Rouillon, il a été invoqué :

- son aptitude à exprimer les symptômes et sa propension au recours médical ;
- ses particularités biologiques, endocriniennes, facteurs de fragilisation ;
- son statut psychosocial :
 - situation de dépendance et d'asservissement au mari,
 - exploitation de l'oblativité maternelle,
 - moindre ouverture vers des fonctions valorisantes ;
- diverses éventualités psychologiques : frustrations, rejets, humiliations et même sacrifices pourraient ébranler le fragile équilibre de la femme : « *On ne sait sous quel poids sa pauvre âme succombe !* »

Mais une autre image peut aussi être évoquée. La société policée a des égards pour elle, les poètes la magnifient, aucune carrière ne lui est fermée ; on la retrouve dans les plus hautes hiérarchies, en tête du gouvernement en divers pays.

Sa fragilité biologique est déjà contestable par sa longévité supérieure. Evoquant même les bienfaits du freinage hypophysaire par les sécrétions ovariennes, certains suggèrent de la promouvoir, à la place de l'homme destitué, dans le « sexe fort ».

Cependant, il est chez la femme certaines particularités : son mode d'aménagement de l'émotion et sa propension à résoudre ses contentieux affectifs dans la névrose, avenue de la dépression. Au contraire l'homme

a plus tendance à transposer dans la délinquance ou l'alcoolisme.

Enfin la dramatisation féminine accentuée, le pudique laconisme masculin estompe et le même état d'âme exprimé dans les items donnera des ombres inégales.

Des auteurs ont montré que les femmes célibataires, veuves ou divorcées semblent moins aptes à se déprimer que les femmes mariées. Le statut social serait donc prévalent par rapport au sexe.

Rouillon rapporte l'étude de Amenson et Lewinsohn : « Ils montrent que si la durée des accès dépressifs est comparable et que la différence de l'incidence entre les hommes et les femmes est très faible ($< 1\%$), c'est surtout le nombre de rechutes qui semble devoir expliquer la différence de prévalence dépressive entre les sexes (21,8 % des femmes déprimées rechutent contre 12,9 % des hommes). »

2. Age. — Les auteurs classiques estimaient la fréquence des dépressions progressivement croissante avec l'âge. Des études plus modernes et rigoureuses remettent en cause cette assertion. Pour certains, au contraire, la prévalence de la dépression diminue avec l'âge. En réalité, les profils des corrélations entre l'âge et la prévalence de la dépression sont différents chez l'homme et la femme. Chez l'homme, la prévalence des dépressions augmenterait à partir de 50 ans, chez la femme, elle culminerait vers 35 ans, particulièrement pour les femmes mariées.

La différence entre les sexes s'estomperait après 65 ans.

Par contre, les dépressions deviennent plus longues, et tendent à la rechute ou à la chronicité, avec l'âge.

3. Insertion professionnelle. — L'existence d'un travail et la qualité de l'insertion professionnelle par les gratifications sociales conférées exerceraient une action bénéfici-

que contre la dépression. Les femmes au foyer se dépriment plus que celles ayant une activité professionnelle ; cela dépend aussi du type d'activité professionnelle.

4. Niveau socio-économique. — Il semble prouvé que la prévalence de la dépression est liée au niveau socio-économique : revenus, conditions de logement et qualité des relations sociales. Selon Rouillon, il peut s'agir d'une cause autant que d'une conséquence car les milieux défavorisés présentent plus d'affections somatiques, facteurs dépressogènes.

Les sujets atteints de PMD bipolaires sont plutôt d'un bon niveau socio-économique.

5. L'influence de l'appartenance ethnique et religieuse et du lieu d'habitation n'est pas démontrée. Il n'a pas été possible de prouver une prévalence supérieure de la dépression en milieu urbain en comparaison du milieu rural. Le rôle pathogène des grands ensembles, des transports en commun et du bruit n'est pas mis en évidence. Par contre, ces éléments pourraient expliquer la fréquence plus élevée d'états névrotiques et de troubles du comportement en zone urbaine.

Chapitre V

D'OÙ VIENT-ELLE ? HYPOTHÈSES ÉTIOLOGIQUES DES DÉPRESSIONS

Les causes de la dépression sont totalement inconnues ; les hypothèses reposent sur des arguments pertinents, mais aucun ne peut expliquer la dépression. Comme pour la schizophrénie, deux théories majeures de la psychiatrie se sont affrontées : la psychogenèse et l'organogenèse.

Pour la première, les anomalies mentales proviennent d'une fragilité venue de l'enfance, perturbée au cours de sa maturation. Les événements actuels, cause apparente de la rupture pathologique, réels ou symboliques, par leur résonance sur un terrain sensible réveillent des images, une blessure affective, un contentieux lointain. C'est la mémoire affective qui se souvient : « D'où surgit, toute vive, une âme qui revient » (Baudelaire).

Pour les partisans de l'organogenèse, le trouble mental provient d'altérations cérébrales. Les phénomènes extérieurs précédant la maladie sont seulement le facteur déclenchant mais celle-ci peut aussi exprimer une programmation génétique. L'opposition dépression endogène et dépression psychogène, d'un dogmatisme manichéen, appelle des réserves.

De plus en plus, les maladies mentales, particulièrement la dépression, sont envisagées selon un détermi-

nisme plurifactoriel où se combineraient divers éléments : génétiques, psychologiques, biologiques et environnementaux. Si certains états semblent exprimer une dominante (biologique ou psychologique), aucun ne peut se prévaloir d'une étiologie exclusive car l'analyse des conditions de survenue, la forme clinique, les données généalogiques montrent, dans une participation inégale, l'intrication d'éléments actuels et de facteurs prédisposants ; même la causalité, rapport qui unit la cause et son effet, est souvent ambiguë ; une perturbation biologique ou psychologique est-elle le motif de la maladie ou sa conséquence ?

I. — Théories génétiques des dépressions

Les théories génétiques de la dépression sont bien argumentées pour les dépressions endogènes, particulièrement dans la psychose maniaco-dépressive bipolaire.

1. Modalités de la recherche génétique. — La recherche de facteurs génétiques dans la dépression s'appuie sur différentes méthodologies. L'étude de l'arbre généalogique avec le repérage des parents atteints (ascendants, collatéraux ou descendants) de la même affection est une approche. L'observation de la pathologie des jumeaux est instructive : il faut distinguer les jumeaux vrais, monozygotes, qui ont le même capital chromosomique, et les faux jumeaux, dizygotes, qui n'ont pas des caractéristiques génétiques identiques, mais des conditions existentielles et affectives similaires. Si une affection est plus souvent concordante chez les vrais jumeaux que chez les faux jumeaux, la composante génétique est très probable.

Les études d'adoption sont aussi informatives puisqu'elles peuvent établir si la pathologie d'un sujet adopté est partagée avec les parents biologiques (héré-

dité biologique) ou avec les parents adoptifs (hérédité de milieu).

Une autre modalité d'investigation moderne est la méthode du *linkage*. L'étude porte sur des éléments cliniques, ou pathologiques, ou chromosomiques particuliers, qui sont transmis de façon concomitante à la dépression, comme s'ils étaient génétiquement liés (*linkage*) à elle.

Les progrès des techniques de biologie moléculaire (sonde génétique) ont permis de déterminer la localisation chromosomique de certaines maladies et de constituants génétiques (*locus*) qui président à l'élaboration et au fonctionnement de systèmes biologiques (codage). Ainsi, certains *locus* codant pour différents éléments biologiques ont été identifiés et localisés sur les chromosomes. Ceux-ci sont constitués d'une succession de gènes. La transmission de la dépression apparaît parfois liée à celle d'autres maladies ou à des *locus* chromosomiques particuliers, permettant alors d'évoquer une localisation génétique de la maladie.

2. Génétique et types de dépression. — Les données génétiques sont probantes pour la psychose maniaco-dépressive bipolaire, probables pour certaines dépressions unipolaires, primaires. Par contre, le déterminisme génétique n'existerait pas dans les dépressions névrotiques.

A) Maladie bipolaire. — Pour les dépressions bipolaires, la participation génétique semble manifeste en regard des taux de concordance de la maladie chez les jumeaux monozygotes et dizygotes. Debray et Cail-
lard, dans *La maladie dépressive*, rapportent des taux de concordance pour la maniaco-dépressive de 25 à 90 % (moyenne : 30 %) chez les jumeaux monozygotes et de 0 à 38 % (moyenne : 10 %) chez les dizygotes ; ces chiffres plaident pour un indiscutable facteur génétique dans la transmission de la maladie.

Chez les sujets maniaco-dépressifs qui ont été adoptés, on détecte plus de troubles de l'humeur ou de pathologies apparentées (alcoolisme) chez les parents biologiques que chez les parents adoptifs. Dans les travaux analysés par Mendlewicz et par Debray et Caillard le risque de la maladie maniaco-dépressive touche les progéniteurs, les frères et sœurs et les enfants dans des proportions qui évoquent une hérédité dominante à gène unique. Les chiffres extrêmes du risque morbide sont :

- chez les parents de 3 à 34 % ;
- dans la fratrie de 3 à 35 % ;
- chez les enfants de 6 à 24 %.

La moyenne se situe donc vers 10 % chez les apparentés du premier degré, soit dix fois plus que dans la population générale.

Ces chiffres évoquent une indiscutable participation génétique, c'est-à-dire que la maladie tend à se manifester si le sujet porte le gène, mais cela n'est pas inéluctable. Mais il faut aussi tenir compte de l'existence de formes non génétiques (phénocopies) et du rôle aggravant ou protecteur du milieu de vie.

Les diverses approches suggèrent donc un facteur constitutionnel dans la maladie bipolaire.

B) *Dépressions unipolaires*. — L'étude génétique des dépressions unipolaires révèle moins de cas familiaux. La participation génétique semble moindre que dans les dépressions bipolaires. Celles-ci constituent un cadre bien défini alors que les dépressions unipolaires sont probablement plus hétérogènes.

Des phénomènes de *linkage* n'ont pas été objectivés dans les familles de déprimés unipolaires.

C) *Troubles dysthymiques*. — L'étude des jumeaux dans les troubles dysthymiques plaide contre une participation génétique.

3. **Les chromosomes dans l'hérédité dépressive.** — Plusieurs postulants sont envisagés comme gènes porteurs de la maladie dépressive au vu des arbres généalogiques et surtout des marqueurs génétiques liés à la maniaco-dépressive et transmis conjointement avec elle (*linkage*).

A) *Chromosome sexuel X.* — Dans certaines familles examinées par Mendlewicz, la transmission héréditaire semble liée au chromosome X.

Mendlewicz et Klein ont montré un lien dans la transmission de la psychose maniaco-dépressive et du daltonisme, affection localisée sur le chromosome X et se transmettant selon les lois de l'hérédité dominante. Les parents des sujets atteints de PMD bipolaire et de daltonisme sont ou exempts des deux maladies ou affectés par les deux qui se révèlent à des moments différents. Dans ce cas, la présence du daltonisme dans l'enfance est annonciateur du trouble de l'humeur à l'âge adulte. Il a aussi été objectivé un *linkage* entre la PMD et un sous-groupe sanguin particulier (Xg) qui renvoie également au chromosome X.

D'autres recherches excluent un rôle du chromosome X et plaident pour d'autres localisations chromosomiques. La transmission par le chromosome X pourrait ne concerner qu'un sous-groupe de maladies dépressives.

B) *Chromosome 11.* — Le chromosome 11 a été aussi incriminé dans la transmission de la PMD bipolaire à partir d'investigations menées dans la population des Amish. Cette secte protestante, très traditionnelle, vit aux Etats-Unis, dans le comté de Lancaster. Les Amish constituent une société fermée, sans migration, sans mariage avec des sujets extérieurs, depuis l'installation des fondateurs. Le taux de consanguinité y est très élevé. Le mode de vie est austère, les règles

morales particulièrement strictes : « Il s'agit donc d'un isolat génétique et culturel, pratiquement autarcique, qui constitue à l'évidence un laboratoire naturel idéal pour les recherches génétiques... » (V. Caillard).

La psychose maniaco-dépressive y est présente et sa transmission a été étudiée de façon rigoureuse. Les dépressions bipolaires sont, dans cette population, aussi fréquentes que les unipolaires alors qu'elles le sont cinq fois moins dans la population générale.

Des études de *linkage* ont été effectuées dans les familles atteintes de PMD ; elles n'ont pas montré de lien entre la transmission de la PMD et celle de marqueurs du chromosome X.

Leurs arbres généalogiques tendent à confirmer la transmission autosomique dominante.

L'étude des gènes à partir de cellules prélevées chez eux montre un lien possible entre la localisation du gène de la PMD bipolaire et deux autres constituants génétiques. Il existe une transmission simultanée de la maladie et de ces deux constituants génétiques situés sur le bras court du chromosome 11, identifiés grâce aux techniques des sondes génétiques. Ce travail met donc en cause le chromosome 11.

C) *Pluralité génétique des dépressions.* — L'existence de plusieurs variétés génétiques de PMD demeure concevable. La constatation d'un *linkage* oriente vers un chromosome mais ne réfute pas pour autant d'autres possibilités génétiques pour d'autres familles maniaco-dépressives. Les techniques de *linkage* vont probablement éclairer les zones d'ombre sur la génétique de la PMD et peut-être la démembrer.

Les études génétiques justifient le bien-fondé de la ségrégation entre formes bipolaires et unipolaires des troubles dépressifs.

II. — Théories biologiques des dépressions

De nombreux arguments plaident pour la recherche de causes biologiques dans les dépressions. D'abord, des dépressions surviennent sans facteur psychologique ou situationnel de déclenchement. Le rythme régulier de certaines rechutes, indépendamment des circonstances, donne l'impression d'un dérèglement biologique interne.

Un second argument est l'existence de syndromes dépressifs, semblables aux accès dépressifs de la PMD, lors de maladies générales comme les maladies endocriniennes, de lésions cérébrales, ou après des traitements médicamenteux (hypertension artérielle) qui provoquent des changements biologiques à l'origine peut-être de dépression.

Le troisième argument fut l'efficacité des antidépresseurs et la mise en évidence de leurs activités biochimiques multiples, au niveau cérébral. L'action des antidépresseurs, dans toutes les variétés de dépression, remet en cause la séparation entre dépressions endogènes biologiques, d'une part, et dépressions névrotico-réactionnelles psychologiques, d'autre part.

Enfin, il fut observé quelques anomalies biologiques chez les déprimés, au niveau de substances sur lesquelles agissent les antidépresseurs.

Les hypothèses biochimiques se sont surtout adressées aux dépressions endogènes particulièrement celles de la PMD.

1. Perturbations de la transmission chimique cérébrale ou neurotransmission. — C'est l'hypothèse la mieux étayée mais contestée.

A) Données générales sur la transmission chimique cérébrale ou neurotransmission. — Les activités, les comportements intellectuels ou affectifs dépendent de systèmes cérébraux précis qui peuvent être localisés et décrits sur

le plan morphologique. Ils sont constitués d'un ensemble de cellules cérébrales qui se transmettent l'influx nerveux qui est une dépolarisation électrique. C'est la mise en activité de ces cellules qui sont responsables des divers comportements et des émotions. Chaque structure cérébrale est dévolue à un ou plusieurs rôles. Chacune est composée de plusieurs groupes de cellules. Celles-ci ne sont pas amarrées les unes aux autres, elles ne se touchent pas mais elles sont séparées par un intervalle appelé « synapse ». L'influx qui est un courant électrique ne pourra donc pas se propager par contiguïté comme dans un fil électrique. Entre deux cellules nerveuses (appelées neurones) l'influx sera véhiculé grâce à des substances chimiques qui permettent ainsi la médiation ou la transmission entre elles : ces substances sont donc appelées neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Ceux-ci peuvent être comparés à des bateaux qui portent un message d'une rive à l'autre d'un fleuve (ici le fleuve est la synapse ou espace séparant deux neurones). Le neurotransmetteur (NT) quitte la cellule présynaptique quand l'influx atteint le bout de cellule : c'est en quelque sorte le signal ou le starter pour larguer les amarres. Le bateau (NT) traverse alors la synapse et arrive pour accoster sur la cellule post-synaptique dans un lieu précis, destiné à le recevoir : c'est son récepteur auquel il se lie comme un bateau entre dans sa cale. Cette liaison recrée l'influx dans la cellule post-synaptique et il se propage à nouveau.

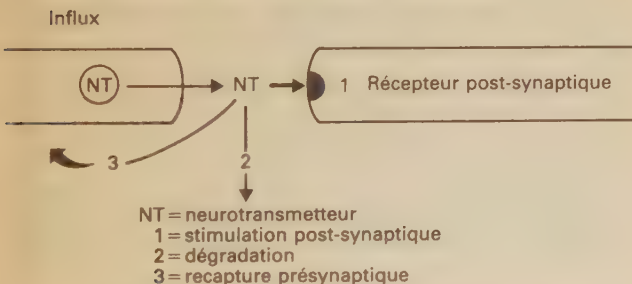
L'influx nerveux est donc successivement entre deux neurones : électrique → chimique → électrique.

En réalité, le neurotransmetteur est libéré en trop grande quantité pour pouvoir être accueilli dans sa totalité sur la membrane post-synaptique. Il y a trop de bateaux (NT) pour les capacités de ce port d'arrivée (post-synaptique). Alors :

- une partie est rappelée au port de départ comme par un souci d'économie pour ne pas risquer de les

abîmer ou de les perdre : ce phénomène est dénommé recapture présynaptique (c'est-à-dire capture effectuée par la cellule présynaptique) ;

— une partie de ces bateaux (les NT) disparaît pendant la traversée sous l'effet d'enzymes qui les attaquent et les transforment en substances inactives (appelées les catabolites), qui sont éliminées de l'organisme. Le destin des neurotransmetteurs comparés à des bateaux peut être ainsi représenté :



Les principaux neurotransmetteurs dans les zones cérébrales qui régulent l'affectivité ou l'humeur (fonction thymique) sont dénommés des monoamines car ils possèdent une seule fonction amine (NH_2) dans leur structure chimique.

Ils sont essentiellement deux dans les parties du cerveau dévolues à la fonction affective :

- la noradrénaline (NA) qui joue également un rôle dans l'éveil, l'effort et la régulation de la tension artérielle ;
- la sérotonine (5 HT) qui intervient dans la régulation du sommeil, de l'appétit, de l'agressivité et de la sexualité.

On comprend ainsi que si ces substances sont perturbées dans la dépression, celle-ci s'accompagne de troubles de l'initiative, de fatigue, d'hypotension arté-

rielle, de perturbations du sommeil, de l'appétit et de la sexualité.

B) Insuffisance de la transmission chimique cérébrale. — Ce fut la première hypothèse. Elle découle de la mise en évidence des activités biochimiques des antidépresseurs. Ceux-ci en effet augmentent la quantité des neurotransmetteurs (c'est-à-dire des bateaux) dans la synapse ; ils favorisent ainsi la transmission de l'influx entre les cellules nerveuses. La manière de parvenir à ce résultat n'est pas la même selon le groupe d'antidépresseurs :

- l'un (groupe de l'imipramine) empêche (inhibition) les bateaux libérés de revenir au port de départ (recapture) : on parle d'inhibition de la recapture présynaptique ;
- l'autre (groupe des IMAO) empêche leur naufrage pendant la traversée en neutralisant les enzymes destructeurs.

Par deux mécanismes différents, les antidépresseurs déterminent donc les mêmes effets : l'augmentation des neurotransmetteurs dans la synapse et donc de la transmission de l'influx. Il fut logiquement évoqué que les antidépresseurs étaient efficaces, en réparant une insuffisance de neurotransmission. C'est la « théorie monoaminergique » puisque ces transmetteurs sont des monoamines. Les antidépresseurs favorisent essentiellement la concentration de deux neurotransmetteurs (noradrénaline ou NA et sérotonine ou 5 HT) dans les circuits cérébraux qui régulent l'humeur. Par ailleurs, ils n'agissent pas tous avec la même intensité pour favoriser l'accumulation de ces deux NT dans la synapse ; certains augmentent surtout la noradrénaline et d'autres la sérotonine. Cette découverte suggère deux catégories biologiques de dépression selon l'insuffisance en cause (NA ou 5 HT).

On a alors recherché si l'on pouvait démontrer une

déficience particulière d'un neurotransmetteur chez les déprimés. L'inconvénient est que les deux substances sont très répandues dans l'organisme, notamment dans certains organes périphériques. Par exemple, la noradrénaline est sécrétée par toutes les fibres du système sympathique et la sérotonine, en large quantité, par des cellules de l'intestin. Les doser dans les liquides biologiques (sang, urine, liquide céphalo-rachidien) ne veut donc rien dire car leur taux résulte des productions cérébrale et périphérique. Ce qui importe dans les dépressions est leur quantité au niveau du cerveau.

Il fut démontré (expériences sur les animaux) que la destruction de ces neurotransmetteurs ne suit pas la même voie dans le cerveau et dans les organes périphériques et qu'elle n'aboutit pas aux mêmes substances (catabolites). Il suffisait donc de mesurer chez les déprimés les substances issues de la destruction cérébrale qui sont aptes à évaluer de façon spécifique les insuffisances en neurotransmetteurs au niveau central.

Ainsi :

- la noradrénaline est détruite en une substance qui se dose dans les urines : le méthoxyhydroxyphénylglycol ou MHPG ;
- la sérotonine se catabolise en acide 5 hydroxyindolacétique ou 5 HIAA qui se mesure dans le liquide céphalo-rachidien.

Le lieu de dosage n'est pas fortuit. Des expériences sur les animaux ont précisé lequel (sang, urine, LCR) était le plus pertinent pour refléter chaque métabolisme cérébral.

Le dosage des substances provenant des neurotransmetteurs ont effectivement montré que :

— Certains déprimés ont des taux anormalement bas de 5 HIAA dans le liquide céphalo-rachidien en comparaison de témoins sains, évoquant une insuffisance cérébrale en sérotonine. Ces déprimés seraient

caractérisés par des propensions suicidaires violentes. Or, les structures, où la sérotonine sert de médiateur chimique, jouent un rôle dans la régulation de l'impulsivité, de l'agressivité, du sommeil et de l'appétit.

En regard des symptômes dépressifs, la théorie de la sérotonine dans la dépression pourrait être un modèle valable ;

— D'autres déprimés présentent une excrétion urinaire de MHPG (venant de la noradrénaline) diminuée. Ils présenteraient plus volontiers une fatigue, une inhibition, une réduction de l'initiative.

L'exploration chez l'homme conforte donc l'hypothèse de l'insuffisance neurotransmission.

Cependant, les anomalies biologiques objectivées peuvent ne pas être la cause mais seulement la conséquence des symptômes de la dépression. Ainsi, la motricité réduite du déprimé peut être responsable d'une baisse de MHPG provenant de la noradrénaline. Chaque signe pathologique peut avoir un concomitant biologique. Il faut concéder que cette théorie est réductionniste en regard des nombreux systèmes biochimiques qui interviennent dans la régulation des comportements.

C) *Maladie des récepteurs cérébraux.* — Cette théorie évoque une anomalie du nombre des récepteurs post-synaptiques, c'est-à-dire des cales dans le port d'arrivée (membrane de la cellule post-synaptique) où viennent se loger les bateaux (neurotransmetteurs). Elle concerne encore les monoamines neuromédiatrices mais selon un modèle différent.

Le nombre des récepteurs où viennent se fixer les NT après leur traversée de la synapse n'est pas fixe mais il se modifie en fonction de leur quantité, afin de maintenir une transmission d'influx assez constante :

— s'il y a beaucoup de neurotransmetteurs, le nombre des récepteurs va tendre à diminuer (fermeture de

certaines cales) pour éviter un excès de stimulation ;

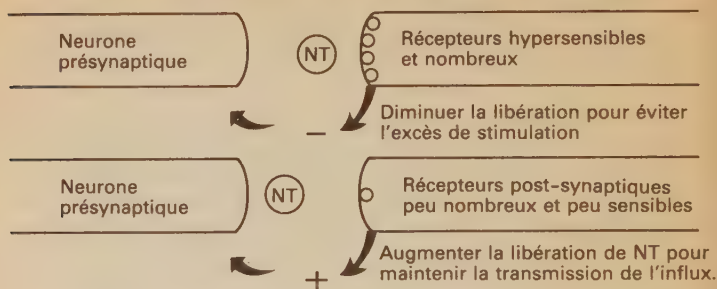
- si, à l'inverse, il y a peu de transmetteurs, le nombre s'accroît (les cales s'ouvrent) pour recevoir au mieux les NT afin de préserver le plus possible la transmission, en compenser le manque.

Tous les traitements antidépresseurs, dont l'électrochoc qui est le plus puissant, déterminent une diminution progressive du nombre de plusieurs types de récepteurs post-synaptiques aux monoamines (5 HT et NA). Il a été démontré chez l'animal que cette diminution sous traitement se produisait en quinze jours à trois semaines, c'est-à-dire le délai nécessaire aux antidépresseurs pour agir de façon positive sur la dépression. Les évolutions clinique et biologique semblent parallèles.

Il est donc logique d'évoquer une hypersensibilité des récepteurs post-synaptiques dans la dépression. Mais alors comment expliquer l'insuffisance de neurotransmetteurs qui a parfois été mise en évidence ? Elle pourrait n'être que la conséquence de cette hypersensibilité. En effet, il existe une boucle de rétro-contrôle (*feed-back*) entre les cellules post-synaptiques et présynaptiques. C'est en quelque sorte une sémaphore sur la berge post-synaptique qui informe le rivage présynaptique de l'arrivée des bateaux neurotransmetteurs. Une arrivée en grand nombre suscite le message : « Arrêtez d'envoyer de nouveaux bateaux, il y en a assez, sinon ils seront en excès. » Ainsi, des récepteurs nombreux ou très sensibles, envoient ce type de missive à laquelle le neurone présynaptique répond en réduisant le départ de nouveaux neurotransmetteurs. Des récepteurs trop nombreux peuvent donc occasionner une réduction de la production de monoamines.

L'ordre peut d'ailleurs être inverse : « Je ne reçois plus assez de bateaux pour propager correctement l'influx, il faut en envoyer plus. » Il y a donc toujours une

interaction entre les deux berges de la synapse pour maintenir un équilibre dans la transmission. Ces phénomènes de régulation peuvent être ainsi représentés.



Ainsi, l'hypersensibilité des récepteurs post-synaptiques pourrait être un élément étiologique dans la dépression, rendant compte secondairement de l'insuffisance en quantité des neurotransmetteurs.

D) *Autres systèmes biochimiques.* — Des perturbations dans d'autres systèmes biochimiques de transmission cérébrale ont été évoquées.

2. **Théorie du « ligand » endogène.** — L'existence d'une substance chimique se liant à des récepteurs fonctionnels (*ligand*) et régulant l'humeur a été évoquée. En effet, des sites où l'imipramine (qui est un antidépresseur) vient se lier avec une très grande affinité, comme une substance physiologique se lie à son récepteur, ont été découverts. Il existe au niveau des plaquettes sanguines et du cerveau des animaux et de l'homme des sites de liaison à très haute affinité pour l'imipramine. Les plaquettes sanguines ont la même origine embryologique que le système nerveux et plusieurs équipements métaboliques identiques à ceux des cellules nerveuses (neurones) à sérotonine. Pour cette raison, la plaquette sanguine est considérée comme un

bon modèle périphérique du neurone cérébral à sérotonine, qui n'est pas accessible à l'investigation directe. La présence des mêmes sites de liaison à l'imipramine dans le cerveau et sur les plaquettes semble authentifier le bien-fondé de cette assimilation. Ces sites de liaison sont couplés avec le système de recapture de la sérotonine ; ils pourraient donc jouer un rôle dans la régulation de la sérotonine cérébrale.

Il a enfin été montré par l'équipe de Langer et notre équipe (E. Zarifian et D. Sechter) que le nombre des sites de liaison à l'imipramine (que l'on peut mesurer par des techniques utilisant la radioactivité émise par l'imipramine marquée au tritium) était en moyenne diminué chez les déprimés, en comparaison des sujets sains, non déprimés. Certains déprimés ont un nombre de sites abaissé et d'autres se situent dans la zone normale. La diminution concerne autant les dépressions endogènes que névrotiques et réactionnelles. Ce constat plaide en faveur d'une unicité de la maladie dépressive.

Aucune caractéristique clinique particulière (sévérité de la maladie) n'a été démontrée chez les déprimés qui présentent un abaissement du nombre de sites. Ces sites possèdent peut-être un rôle fonctionnel et constituent d'authentiques récepteurs sollicités par un *ligand* spécifique qui pourrait participer à la régulation de l'humeur, peut-être par l'intermédiaire des systèmes à sérotonine.

3. Théories endocriniennes. — Presque toutes les maladies endocriniennes (thyroïde, cortico-surrénales, glandes sexuelles) peuvent se compliquer d'accès dépressifs.

Au cours des dépressions, des modifications variées des hormones ont été rapportées mais elles sont inconstantes et peu spécifiques. L'anomalie endocrinienne la plus souvent retrouvée, chez la moitié des déprimés, consiste en une sécrétion accrue de cortisol par la glande cortico-surrénale.

La production de cortisol est stimulée par une hormone hypophysaire, l'ACTH (Adéno-Cortico-Trophine Hormone). Celle-ci est elle-même stimulée par une neurohormone, le CRF (Corticotrophin-Releasing-Hormone) qui vient du diencephale, structure située à la partie inférieure du cerveau.

La production de cortisol dans le sang freine, par rétrocontrôle, la production de CRF et d'ACTH. Dans les dépressions, il y a une production accrue de cortisol qui semble incapable de diminuer en retour la production de CRF et d'ACTH. Donc le processus normal de freinage ne se produit pas et une production excessive de cortisol persiste dans les dépressions. Le test de freination à la dexaméthasone objective cette hypersécrétion qui peut passer inaperçue à un seul dosage sanguin du cortisol ; celui-ci subit en effet des variations importantes dans le cours de la journée et sous l'effet de nombreux facteurs (émotion, anxiété, exercice, digestion, etc.).

La dexaméthasone est une cortisone synthétique. Lorsqu'on en administre 1 mg à un sujet, elle freine le CRF, donc l'ACTH et, par voie de conséquence, la production de cortisol diminue. Cet effet dure plus de vingt-quatre heures après une prise unique de dexaméthasone. Chez presque la moitié des déprimés, l'absorption de dexaméthasone n'entraîne pas de chute du taux de cortisol sanguin (absence de freination), ou une chute éphémère pendant quelques heures, le cortisol retournant trop rapidement aux taux antérieurs (échappement à la freination). Ce test est alors dit anormal. En l'absence de maladie endocrinienne, l'anomalie serait assez spécifique de la maladie dépressive et disparaîtrait avec la guérison.

Cette perturbation endocrinienne n'exclut pas les théories monoaminergiques car les monoamines interviennent aussi dans la régulation de l'axe corticotrope (CRF → ACTH → cortisol). La sérotonine stimule la production de CRF et la noradrénaline l'inhibe.

Des anomalies ont été également objectivées au niveau de la glande thyroïde, de la prolactine (hormone de la lactation), de l'hormone lutéotrope et de l'hormone de croissance.

4. Théories chronobiologiques. — De nombreux éléments biologiques (sécrétions hormonales, substances monoaminergiques...) présentent des variations rythmiques dans le temps. Elles augmentent à certaines heures de la journée et diminuent à d'autres. Ces fluctuations seraient sous l'influence d'horloges internes régulatrices situées dans une zone cérébrale particulière, l'hypothalamus. Ces horloges sont influencées par différentes sollicitations de l'environnement externe (comme l'alternance jour-nuit) appelées synchroniseurs externes.

Les dépressions pourraient provenir d'une désorganisation des rythmes biologiques qui seraient « désynchronisés ». Ces anomalies sont surtout évidentes dans les dépressions de la PMD. Chez les déprimés, surtout endogènes, existent des altérations des rythmes de la température corporelle, des différents stades du sommeil, de nombreuses sécrétions hormonales (cortisol, ACTH, prolactine, hormones thyroïdiennes), des monoamines (5 HT, NA) et de leurs produits de dégradation, et enfin de la mélatonine qui est une substance dont la sécrétion est très dépendante du facteur lumière-obscurité. Les rythmes biologiques altérés se normalisent à la guérison de la dépression. Le désordre chronobiologique est-il cause ou conséquence de la dépression ? La question n'est pas élucidée.

Ainsi, les recherches biologiques dans les dépressions ne sont pas stériles ; la récolte est si diversifiée qu'il est difficile d'esquisser une valable théorie biologique des dépressions, de relier les anomalies repérées et de leur conférer un sens étiologique. Certaines anomalies dérivent probablement des symptômes cliniques de la dépression. Ainsi, la perte du sommeil, la réduction de

l'appétit, l'anxiété ont probablement leurs concomitants biologiques qu'il serait abusif d'ériger en cause.

III. — Théories environnementales : facteurs prédisposants et facteurs déclenchants

Les événements traumatiques précoces semblent prédisposer aux ruptures dépressives à l'âge adulte. Des antécédents de perte d'un parent, par séparation ou décès, seraient retrouvés avec un pourcentage plus élevé dans les dépressions, comparativement aux sujets non déprimés. Cependant, pour certains auteurs, les pertes précoces ne constituent pas un facteur étiologique prépondérant mais elles influencent l'expression sémiologique de la dépression : le deuil prédispose plutôt à la dépression psychotique et la séparation à la dépression névrotique. Mais, dans les PMD, il n'est pas démontré une plus grande incidence de pertes parentales précoces.

Des événements vitaux affligeants précèdent souvent l'apparition d'un accès dépressif, que celui-ci soit endogène ou névrotico-réactionnel. Ils sont considérés comme facteurs précipitants ou déclenchants. Des auteurs ont mis en évidence un nombre d'événements stressants plus élevé dans l'année précédant le début d'une psychose maniaco-dépressive que chez les autres sujets. Il n'y aurait pas de différence entre les formes uni- et bipolaires bien que quelques études enregistrent légèrement plus de facteurs précipitants dans les formes bipolaires. La comparaison des dépressions psychogènes névrotico-réactionnelles et des dépressions endogènes psychotiques objective un plus grand pourcentage d'événements traumatiques dans la première catégorie ; mais la différence est peu significative, contrairement à ce que laisse supposer cette dichotomie. Une étude de Matussek et Namer ne trouve pas

de différence de pertes de parents (conjoint, enfant, parents, frère et sœur) entre déprimés endogènes, déprimés névrotiques et sujets normaux ; mais dans l'année précédant la rupture dépressive, les pertes par séparation sont plus fréquentes dans les dépressions névrotiques alors que celles par décès sont identiques entre les deux groupes.

Les événements vitaux influenceraient moins la survenue des rechutes que celle de l'épisode inaugural. Les agents stressants favorisent la survenue d'une dépression mais ils semblent rarement en constituer la cause unique.

En fait, la dépression surviendrait si les facteurs prédisposants issus de l'enfance et les facteurs précipitants dans l'existence récente s'additionnent. Isolément, chacun ne serait pas suffisant.

IV. — Théories psychanalytiques

Les théories psychanalytiques s'articulent autour des notions de deuil, de perte, de frustration, de préjudice et d'expériences infantiles traumatiques rendant le sujet adulte vulnérable aux ruptures dépressives. Abraham et Freud furent les premiers à élaborer une théorie psychodynamique de la dépression.

1. **Karl Abraham.** — Pour cet auteur, le moteur des ruptures dépressives consiste en des tendances sadiques, une « disposition haineuse » envers l'extérieur. Il en découle une incapacité à aimer les autres et une propension à les détester qui s'accompagne d'un sentiment de culpabilité. Les tendances sadiques sont retournées contre le sujet dans les thèmes d'autodévalorisation ou d'auto-accusation mélancoliques. Dans la mélancolie, ce sadisme qui caractérise le stade anal du développement de la personnalité est renforcé par une régression au stade oral où la destructivité est plus

violente encore. D'après Abraham, cette régression est favorisée par des déceptions très précoces dans la relation de l'enfant avec ses parents.

2. Sigmund Freud. — Freud expose sa première théorie dans « Deuil et mélancolie » en 1915. Le deuil, « réaction à la perte d'une personne aimée ou d'une abstraction mise à sa place », perte réelle ou symbolique, a des similitudes cliniques avec la mélancolie : tristesse, douleur morale, désintérêt pour le monde extérieur. La mélancolie est un deuil mais qui ne peut s'effectuer selon les étapes habituelles où l'objet perdu est progressivement désinvesti par un véritable processus psychologique (travail de deuil) au profit de nouveaux centres d'intérêt ou d'amour se substituant à lui. Dans le deuil, l'objet perdu est reconnu du sujet. Deux notions caractérisent la mélancolie : l'objet perdu n'est pas consciemment identifié par le sujet et le sujet s'avère incapable d'assumer cette perte symbolique de l'objet. Le sujet porte des sentiments agressifs de dépit à l'objet perdu puisqu'il a, en quelque sorte, été abandonné par lui ; mais, en même temps, pour éviter cette perte impossible à assumer, le sujet s'identifie à l'objet de façon narcissique ; ainsi se comprennent les tendances auto-agressives dans la mélancolie qui sont en réalité destinées inconsciemment à l'objet perdu, assimilé au sujet. Le mélancolique s'avère incapable, comme dans le déroulement du deuil, de déplacer ses investissements affectifs (libido) de l'objet extérieur perdu à un autre objet extérieur. Pour expliquer l'impossibilité de cette translation de la libido indispensable à certains moments de l'existence, Freud suppose que les sujets n'ont pas établi de relation affective adulte avec le monde externe. Ils ont une relation pathologique aux objets extérieurs. Cette relation d'objet est en réalité narcissique, l'amour de l'objet étant subordonné à ce qu'il apporte de gratifications in-

conscientes au sujet. Il y a une sorte de collusion entre l'amour de soi et l'amour de l'autre.

La mélancolie, toute empreinte d'ambiguïté, doit être comprise comme un retour des affects (libido) du monde extérieur vers l'intérieur du sujet.

A l'inverse du deuil où la perte est réelle, la rupture mélancolique peut être catalysée par une perte minime, en apparence inexistante, même imaginaire. C'est l'écho symbolique dans l'inconscient, la valeur fantasmatique de la perte, qui induit le processus mélancolique. L'amalgame du moi du mélancolique à l'objet perdu par identification narcissique correspond pour Freud et Abraham à une régression à la phase orale du développement psychique.

Plus tard, Freud, après avoir formulé le concept du surmoi, estimera que la culpabilité mélancolique provient d'un conflit entre les exigences du surmoi et le moi : « L'angoisse de mort de la mélancolie n'admet que cette seule explication : le moi s'abandonne parce qu'il se sent haï et persécuté par le surmoi au lieu d'être aimé. »

3. Melanie Klein. — Pour cet auteur, la dépression serait une reviviscence, lors de certains événements, des ambiguïtés affectives éprouvées lors d'une étape du développement de l'enfant qu'elle dénomme la position dépressive. Initialement l'enfant ne reconnaît pas une personne, un objet extérieur dans son intégralité. Ainsi le sein qui le nourrit et la main qui le couche dans son berceau ne sont pas intégrés comme éléments d'une même entité, la mère.

Ce stade, dit de l'objet partiel, correspond pour Melanie Klein à une position « schizoparanoïde ». Puis l'enfant va identifier les objets extérieurs dans leur unité ; ainsi il va reconnaître que le sein et la main appartiennent à la même personne. Alors l'enfant se déprime car il prend conscience de l'ambivalence de ses sentiments : il aime le sein qui le nourrit et déteste la

main qui l'en écarte. Dans cette période, l'enfant craint que ses sentiments de haine à l'encontre d'une partie de la personne aimée ne la détruise. Dans les dépressions, le sujet vit à nouveau de tels affects où se mélangent l'agressivité et l'amour à l'égard du monde extérieur et de lui-même. Un autre apport de Melanie Klein est de considérer l'excitation maniaque comme un mode de défense contre la mélancolie.

4. Jacques Lacan. — Jacques Lacan reprend l'idée de Freud : la souffrance masochique s'accompagne d'une certaine jouissance. Les concepts de jouissance et de pulsion de mort sont essentiels dans la pensée de Lacan. La jouissance s'oppose au plaisir, gardien de la vie ; le plaisir fait barrière à la jouissance qui excédant toute limite conduit à la mort. La jouissance sans limite et mortifère est la direction inconsciente de la pulsion de mort.

Freud expliquait la pulsion de mort par une tendance inhérente à l'organique, de retourner à l'état inorganique. Lacan le formule autrement : l'être humain, du fait qu'il parle, est un être-pour-la-mort. Son accession au langage, au symbolique, est corrélative du surgissement de la pulsion de mort.

Pour Lacan, la pulsion de mort n'est pas réservée à une catégorie de sujets « malades », mais est constitutive de l'être humain : « La vie dont nous sommes captifs, vie essentiellement aliénée, est conjointe à la mort... la vie ne songe qu'à se reposer le plus possible en attendant la mort... la vie ne songe qu'à mourir... la vie est un détour dépourvu de signification. »

Ses conceptions éclairent la compréhension des dépressions, bien que Lacan ne les ait pas spécifiquement envisagées.

5. Autres auteurs. — Pour Spitz, les carences affectives précoces sont un élément fondamental dans la survenue ultérieure de dépression. Il décrit la dépres-

sion anaclitique chez des enfants privés de leur mère pendant trois mois de façon permanente, après avoir bénéficié d'une relation maternelle normale. L'enfant présente alors une phase de protestation avec cris et pleurs, puis une phase de renoncement avec apathie, retrait apparent, désintérêt, ralentissement, voire arrêt du développement psychomoteur. L'absence de restauration d'une relation maternelle normale augure de propensions dépressives à l'âge adulte.

Edith Jacobson souligne la notion de perte de l'estime de soi dans la mélancolie.

Dans l'ensemble, les théories psychanalytiques retiennent comme déterminants la qualité des relations entre le sujet au cours de son développement et le monde extérieur et leurs divers aléas existentiels ou imaginaires : perte, séparation, régression.

V. — Théories cognitives

Le terme cognition est actuellement très employé, sans définition, ni délimitation précises. Il désigne l'ensemble des processus par lesquels le cerveau traite les informations, les reçoit, les intègre et y répond de façon verbale et comportementale. L'adjectif cognitif renvoie ainsi à la vigilance, à l'attention, à l'apprentissage, à la mémoire, à la compréhension et à l'adaptation.

Les bases des théories cognitives de la dépression ont été établies par Beck et par Seligman.

Dans les théories cognitives, le cerveau est implicitement comparé à un ordinateur. Dans la dépression il existe une perturbation des processus qui transforment les informations en représentations mentales.

La théorie de la dépression de Beck se fonde sur un sous-entendu manichéen, véritable postulat : il existe des représentations positives et des représentations négatives.

Les dépressions se caractérisent par des symptômes cognitifs qui sont « une façon de penser » particulière, stéréotypée, presque monolithique. Pour Beck, les pensées du déprimé sont toutes empreintes d'un jugement négatif sur lui-même, le monde extérieur et l'avenir : « triade cognitive négative ».

La dépression ferait irruption à la suite d'une perte ou d'un traumatisme. La triade cognitive négative en attribue inévitablement la responsabilité au sujet qui en éprouve de la culpabilité. Les théories cognitives s'adresseraient essentiellement aux dépressions exogènes. La dépression provient de l'histoire du sujet. Celui-ci a subi des expériences dépressogènes et son cerveau en garde une empreinte cognitive dépressive susceptible de se réactiver à l'occasion de circonstances pénibles.

Selon les théories cognitives, la manière de penser du déprimé est caractérisée par des anomalies du traitement de l'information, ou « distorsions cognitives », qui sont bien répertoriées et comprennent :

- les inférences arbitraires : le sujet tire des conclusions sans preuves ; exemple : mon ami ne m'a pas téléphoné, il ne m'aime donc plus, personne ne m'aime ;
- l'abstraction sélective : le sujet centre son attention sur un détail et méconnaît le contexte dans sa globalité ; les détails retenus se situent dans une vision négative renvoyant à l'échec, au rejet, à l'impuissance... ; exemple : j'ai mal dit bonjour à mon patron, il va me licencier ;
- l'attribution interne : le sujet s'attribue constamment des responsabilités dans les événements ;
- la pensée dichotomique : les évaluations sont effectuées par le sujet sans nuances, en véritable loi du « tout ou rien » ; exemple : je suis incapable car je n'ai pas tout à fait fini mon travail.

Ainsi le déprimé estime qu'il n'existe aucune issue à sa situation.

Les distorsions cognitives sont responsables d'une production excessive de pensées négatives et d'interprétations pessimistes de l'expérience vécue. Dans la perspective cognitive, la tristesse et les autres troubles dérivent des perturbations cognitives, c'est-à-dire des pensées et des convictions qu'elles engendrent.

Des travaux modernes ont montré que :

- la triade de Beck n'est pas une condition nécessaire à l'état dépressif ;
- les pensées négatives sont corrélées aux scores de dépression mesurés par les échelles d'évaluation mais ils n'ont pas de rapport avec les scores d'anxiété.

Dans la perspective cognitive, un rôle prépondérant est donc accordé à la pensée et à la représentation mentale, mais la dépression n'est-elle pas la faillite de toutes les facultés du sujet ? La prévalence du cognitif est-elle réaliste ? La pensée négative est-elle le *primum* de la dépression ou seulement une illustration du pessimisme dépressif ?

La théorie cognitive méconnaît la complexité de l'organisation interne du sujet, les interconnexions affectivo-intellectuelles. Elle subordonne la sémiologie dépressive aux pensées négatives, c'est-à-dire l'affect au raisonnement.

Dans la dépression, ce n'est peut-être pas la qualité de la pensée qui est perturbée mais la capacité à penser. La faillite globale de la pensée, de la volonté, de la capacité à ressentir et à agir, serait peut-être source des pensées négatives autodépréciatives.

Troubles cognitifs au cours des dépressions. — Les plaintes sur des difficultés intellectuelles d'attention, de

concentration, de mémoire sont habituelles dans les dépressions.

Les investigations psychométriques ont pu mettre en évidence des perturbations de l'efficiencia, des capacités d'abstraction, d'apprentissage, de synthèse et de mémoire au cours des dépressions. Mais il est difficile de rattacher les troubles cognitifs à un élément du processus dépressif. L'humeur, l'anxiété surtout, perturbent les virtualités intellectuelles. Le désintérêt, le ralentissement, la difficulté d'analyse et de synthèse, l'absence de motivation, peuvent induire une attitude, une évaluation négatives et des pensées erronées. Les troubles cognitifs, sans en constituer le pivot central, sont un aspect de la dépression.

Le mystère demeure : prévalence d'un déterminisme interne ou des événements extérieurs ? La combinaison capricieuse des divers facteurs peut, sans en modifier la nature, façonner chaque aspect de la maladie dépressive.

Chapitre VI

COMMENT GUÉRIR LES DÉPRESSIONS ? OU LES TRAITEMENTS

Les traitements des dépressions comportent deux temps, l'un curatif et l'autre préventif des rechutes. Le premier est dominé par la chimiothérapie antidépressive, le second renvoie, selon les cas, aux psychothérapies, aux aménagements existentiels ou aux régulateurs de l'humeur. Les trois mesures s'avèrent souvent complémentaires.

I. — Traitements curatifs

1. Les traitements avant l'ère de l'électrochoc et des antidépresseurs. — Les médicaments des dépressions au début du siècle visaient à apaiser la souffrance morale du malade, à favoriser le sommeil, à endiguer les propensions suicidaires par une sédation globale.

Un dérivé de l'opium, le laudanum de Sydenham*, était efficace sur l'anxiété. Les substances barbituriques, type Gardénal*, utilisées dans l'épilepsie, avaient des propriétés identiques. Le chloral, somnifère, aidait à rétablir le sommeil.

Ces médicaments apportaient un apaisement, sans constituer un traitement spécifique.

2. L'électrochoc : premier traitement des dépressions.

— L'introduction de l'électrochoc (ECT) par Cerletti reposait sur un postulat faux : l'antagonisme de l'épilepsie et de la schizophrénie. Avant l'électrochoc, différentes techniques, souvent pénibles pour le malade, cherchaient à provoquer des crises d'épilepsie. Cerletti eut l'idée simple de provoquer la crise par l'administration dans le cerveau de courant électrique.

L'électrochoc consiste à administrer, à l'aide de deux électrodes placées sur les tempes, une décharge électrique suffisante pour déterminer une perte de connaissance et une crise d'épilepsie généralisée (l'épilepsie est une hyperactivité électrique des cellules nerveuses qui se dépolarisent toutes en même temps).

Dès le début de son emploi, les troubles de l'humeur, dépression et agitation, sont apparus comme les indications privilégiées. Les améliorations dans la schizophrénie étaient partielles, souvent transitoires.

L'utilisation extensive de la méthode entre 1938 et 1957 est due aux résultats et à l'extrême dénuement thérapeutique.

L'excès de prescription de l'électrochoc et les conditions de son application avec leurs aléas (sans anesthésie, choc électrique sans perte de connaissance, arrêt respiratoire et cyanose) expliquent l'opprobre dont il fut l'objet entre 1960 et 1980.

Depuis 1960, la curarisation empêche le passage de l'influx nerveux à ses effecteurs, notamment aux muscles. Les secousses convulsives sont ainsi évitées. Mais les muscles respiratoires étant paralysés (une minute environ grâce aux curares d'action brève), il est nécessaire de pratiquer une respiration artificielle. L'électrochoc est effectué par un anesthésiste réanimateur ; on dit aujourd'hui électronarcose sous curare, car la crise a lieu sous sommeil provoqué (narcose). La sécurité est absolue. La découverte des antidépresseurs a réduit le recours à l'électronarcose dont les indications sont au-

jourd'hui codifiées. Plutôt néfaste dans les dépressions névrotiques, elle s'adresse aux mélancolies endogènes.

Elle peut, dans certaines formes graves, être envisagée d'emblée, avant tout traitement antidépresseur ou après échec de celui-ci.

L'ECT s'impose sans délai dans certaines situations :

- les mélancolies délirantes où les antidépresseurs et les neuroleptiques (substances anti-délirantes) sont insuffisants. Les antidépresseurs seuls donnent 30 % de bons résultats, les neuroleptiques seuls 50 %, l'association des deux 65 % et l'ECT 90 % de guérisons ;
- dans les dépressions anxieuses, où le risque suicidaire est majeur pendant le délai d'action de quelques semaines des antidépresseurs ;
- les dépressions stuporeuses avec refus d'alimentation ;
- dans les dépressions graves après accouchement, souvent rebelles aux antidépresseurs ;
- dans les mélancolies où les antidépresseurs sont interdits (cardiaques, sujets âgés).

L'électronarcose peut être envisagée en seconde instance, dans les dépressions endogènes où les antidépresseurs prescrits à doses suffisantes pendant au moins trois semaines n'ont pas agi.

Les sujets âgés, avec ralentissement psychique marqué, bénéficient parfois de façon spectaculaire de l'électronarcose, sans incidence sur le vieillissement cérébral ; le traitement démontre que l'apparente détérioration était en réalité une « pseudo-démence dépressive ».

L'électronarcose a peu de contre-indications (insuffisance cardiaque ou respiratoire évoluée) mais elle induit parfois des troubles secondaires de deux ordres : certains éphémères après le réveil (maux de tête, nausées, vomissements), d'autres plus importants, variables selon les sujets, indépendants de l'âge : les altéra-

tions de la mémoire. L'ECT n'altère pas les faits anciens déjà engrammés mais il gêne la mémoire des événements vécus pendant la cure. Même les sujets jeunes peuvent présenter des « trous de mémoire » allant jusqu'à plusieurs semaines. Ils sont totalement régressifs en deux à quatre mois et souvent de plus courte durée. Certains opposants à l'ECT l'ont accusé de « briser les idées », préférant la souffrance morale du malade : un choix idéologique à l'usage des autres !

Une variante technique (ECT unilatéral) par application des deux électrodes sur un seul côté du crâne en regard de l'hémisphère non dominant (droit chez le droitier) réduit les troubles de la mémoire mais parfois semble moins efficace.

L'électronarcose dans les dépressions endogènes est plus rapidement et constamment efficace que les antidépresseurs (90 % de guérison pour ECT, 65 % pour les antidépresseurs). Récemment, un psychiatre américain, dont le malade s'était suicidé, fut condamné pour ne pas l'avoir pratiqué après divers échecs thérapeutiques.

3. Les antidépresseurs. — Ils constituent le traitement essentiel de toutes les dépressions.

A) Définition. — Ce sont des substances qui corrigent ou relèvent l'humeur dépressive. On les classe dans le groupe des stimulants psychiques ou psychoanaleptiques. Pour caractériser leur action prévalente sur l'humeur ou fonction thymique, ils sont dénommés thymoanaleptiques. Ils n'ont pas d'action sur la vigilance, hormis les antidépresseurs dits sédatifs, susceptibles de l'entraver.

Les antidépresseurs ont la propriété de redresser l'humeur dépressive et parfois, dépassant le but, de l'inverser en euphorie maniaque (50 % chez les bipolaires et 10 à 15 % chez les unipolaires).

Leur action thérapeutique est totalement différente

de celle des tranquillisants avec lesquels ils sont souvent confondus.

B) *Historique de la découverte des antidépresseurs.* — Les chefs de file des deux principales catégories d'antidépresseurs furent découverts en 1957.

— L'iproniazide (Marsilid*), dérivé de l'isoniazide (Rimifon*), fut remarqué pour ses propriétés antidépressives par Nathan Kline et son équipe. Il est à l'origine des inhibiteurs de la mono-amino-oxydase (IMAO). Essayé dans la tuberculose, les expérimentateurs rapportaient une « stimulation du système nerveux central » comme effet latéral majeur. Les malades apparaissaient plus dynamiques, gais, reprenaient de l'appétit alors que les lésions tuberculeuses ne régressaient pas. Il fut alors appliqué en psychiatrie et rapidement considéré comme un « énergiseur », améliorant les dépressions et même stimulant parfois les sujets névrotiques asthéniques et les schizophrènes repliés et inactifs.

— L'imipramine (Tofranil*) est le père des antidépresseurs dits tricycliques. En 1952, la découverte des propriétés de la chlorpromazine (Largactil*) transformait le comportement des malades et l'ambiance des services de psychiatrie.

Le médicament calmait l'agitation, réduisait le délire, particulièrement les hallucinations et l'agressivité des malades mentaux. L'imipramine, de structure proche de la chlorpromazine, fut testée par différents expérimentateurs dans les états d'agitation et la schizophrénie. Résultat médiocre et abandon du produit. Le Suisse Roland Kuhn l'essaye, sans *a priori*, et découvre son efficacité dans les dépressions endogènes.

C) *Classifications des antidépresseurs.* — La classification des antidépresseurs s'est limitée pendant des années à l'opposition entre les tricycliques, dérivés de l'imipramine, et les inhibiteurs de la mono-amino-oxy-

dase (IMAO), dérivés de l'iproniazide. Elle est improprement appelée classification chimique car, si la dénomination « tricyclique » fait référence à la structure chimique (molécules composées de trois cycles), par contre, la notion d'inhibiteur de la mono-amino-oxydase renvoie à une action biologique : les IMAO, dont les structures chimiques sont diversifiées, ont la propriété d'inhiber une enzyme, la mono-amino-oxydase, qui dégrade dans le cerveau de nombreuses substances dont les monoamines : sérotonine (5 HT), noradrénaline (NA) et dopamine (NA), considérées comme des neurotransmetteurs essentiels.

D'autres antidépresseurs, ni tricycliques, ni IMAO, sont apparus, désignés sous les termes de « nouveaux antidépresseurs » ou « antidépresseurs de seconde génération ».

Tous les antidépresseurs exercent des activités sur les neurotransmetteurs monoaminergiques mais ils n'interfèrent pas sur les monoamines de la même façon : ce constat amène à une classification biochimique.

Enfin, chaque antidépresseur possède des qualités thérapeutiques latérales, adjointes à l'activité antidépressive principale, qui définissent un spectre d'activité thérapeutique pour chaque molécule. On peut donc dégager trois classifications : chimique, biochimique et thérapeutique.

a) Classification chimique des antidépresseurs. — Elle distingue trois classes essentielles :

— *Les tricycliques et composés apparentés* constituent le groupe le plus important. Ils sont représentés dans le tableau 1 avec le nom international issu de la structure chimique, le nom de commercialisation et le mode de présentation. Tous les antidépresseurs ont une forme pour l'absorption orale (comprimés, gélules, gouttes) ; certains peuvent également être administrés par voie intramusculaire (IM) ou en perfusion intraveineuse (IV).

Tableau 1. — Antidépresseurs tricycliques

<i>Dénomination internationale</i>	<i>Nom de commercialisation en France</i>	<i>Présentation</i>
Imipramine	Tofranil*	cp, amp IM
Désipramine	Pertofran*	cp, amp IM
Amitriptyline	Laroxyl*	gtes, cp, amp IM ou IV
	Elavil*	cp
Trimipramine	Surmontil*	cp, gtes, amp IM ou IV
Clomipramine	Anafranil*	cp, amp IM ou IV
Opipramol	Insidon*	cp
Dosulépine	Prothiaden*	gél
Quinupramine	Kinupril*	gél, amp IV
Doxépine	Sinéquan*	gél, amp IM
	Quitaxon*	cp, gtes
Déméxiptiline	Tinoran*	cp
Propizépine	Vagran*	gél
Amineptine	Survector*	cp
Amoxapine	Défanyl*	cp, gtes
Tianeptine	Stablon*	cp
Maprotiline	Ludiomil*	cp, amp IV
(quadricyclique apparenté aux tricycliques)		

Légende : cp = comprimé ; gtes = gouttes ; +
gél = gélule ; amp IM = ampoule pour
administration intramusculaire ; amp IV =
ampoule pour administration intraveineuse.

Le dosage des présentations diffère d'un composé à l'autre ; un même produit peut avoir plusieurs présentations avec des posologies différentes.

— *Les inhibiteurs de la mono-amino-oxydase* sont peu nombreux. Ce sont :

Tableau 2. — Antidépresseurs IMAO

Iproniazide	Marsilid*	cp
Nialamide	Niamide*	cp
Toloxatone	Humoryl*	gél
Moclobémide	Moclamine*	cp

Le Marsilid* et le Niamide* ont une activité biologique prolongée après l'arrêt de leur prise, alors que celle de l'Humoryl* et de la Moclamine* cesse dans les vingt-quatre heures après la dernière absorption. Ils sont donc désignés comme des IMAO réversibles.

— *Les antidépresseurs de nouvelle génération* renferment des produits de structures variées :

Tableau 3. — Antidépresseurs
de nouvelle génération

Viloxazine	Vivalan*, Vivalan LP*	cp, amp IM ou IV
Miansérine	Athymil*	cp
Trazodone	Pragmarel*	gél, cp
Fluvoxamine	Floxyfral*	cp
Médifoxamine	Clédial*	cp
Oxaflozane	Conflictan*	gtes
Fluoxétine	Prozac*	gél

Les avis divergent sur les propriétés antidépressives du lithium.

Des composés potentiellement antidépresseurs (citalopram, minalcipran...) sont à l'étude.

Malgré la pléthore des antidépresseurs, la recherche de nouvelles molécules poursuit trois objectifs : efficacité plus constante, rapidité d'action accrue, moindre incidence d'effets latéraux.

b) Classification biochimique. — Les IMAO empêchent la destruction des neurotransmetteurs libérés dans la synapse pour la transmission de l'influx. Ils en augmentent donc la concentration et favorisent ainsi l'influx. Les tricycliques et les nouveaux antidépresseurs inhibent la recapture présynaptique des monoamines après leur libération : celles-ci s'accumulent aussi dans la synapse. Par des mécanismes différents, les différents antidépresseurs aboutissent au même résultat.

Cependant, les tricycliques et les nouveaux antidépresseurs n'agissent pas avec la même puissance sur les

diverses monoamines. Certains favorisent la transmission par la sérotonine, d'autres par la noradrénaline ou la dopamine. L'hypothèse a été émise qu'il pourrait exister différentes catégories biologiques de dépression en référence à un système monoaminergique déficient : dépression par manque en sérotonine ou en noradrénaline ou en dopamine. Les antidépresseurs peuvent être séparés en cinq groupes :

— action sur les 3 monoamines	IMAO
— action mixte NA + 5 HT	Tofranil*
— action prépondérante ou exclusive sur la NA	Athymil*
	Ludimil*
	Kinupril*
— action prépondérante ou exclusive sur la 5 HT	Laroxyl*
	Anafranil*
	Floxyfral*
	Prozac*
	Stablon*
— action sur la DA	Survector*

Les antidépresseurs agissent initialement sur un système. Mais l'administration prolongée sur plusieurs jours aboutit à des modifications communes de sensibilité de plusieurs récepteurs aux monoamines. Ainsi, presque tous les antidépresseurs diminuent le nombre et la sensibilité de récepteurs à la noradrénaline (dits récepteurs bêta) et de certains récepteurs à la sérotonine (5 HT 2).

On ignore si l'action des antidépresseurs sur les monoamines et leurs récepteurs sous-tend leurs propriétés thérapeutiques.

Les antidépresseurs peuvent être classés selon leur puissance anticholinergique ; certains sujets sont particulièrement sensibles à cette action, responsable de troubles indésirables tels constipation, sécheresse de la bouche, tremblement. Des antidépresseurs sont dépourvus de cette activité : Athymil*, Valalan*, Floxyfral*, Prozac*, Stablon* et IMAO.

c) *La classification thérapeutique.* — Tous les antidépresseurs semblent avoir la même puissance antidépressive. Cependant, ils n'ont pas tous les mêmes effets thérapeutiques en début de prescription. Kielholz observe que les antidépresseurs possèdent, à côté de leurs qualités thymoanaleptiques, des propriétés « latérales », soit stimulantes ou psychotoniques ou désinhibitrices, soit sédatives ou anxiolytiques. Il propose une classification bipolaire des antidépresseurs d'un pôle psychotonique à un pôle sédatif anxiolytique. Dans ce schéma s'opposent :

- les antidépresseurs sédatifs, actifs sur l'anxiété et ses expressions : insomnie, agitation ;
- et les antidépresseurs stimulants actifs sur la fatigue et l'inhibition psychomotrice.

Entre les deux groupes se situent les antidépresseurs dits médians ou intermédiaires, plutôt stimulants ou sédatifs selon les sujets et peut-être la posologie. Ainsi, le Tofranil* et l'Anafranil* peuvent être ressentis de manière très différente selon les déprimés : les uns se plaignent d'énervement, d'hyperémotivité, de fébrilité et d'autres déplorent un abattement, une somnolence.

La classification thérapeutique des antidépresseurs est présentée dans le tableau 4.

L'intérêt pratique de cette classification est d'adapter la prescription à la sémiologie de la dépression. Les propriétés stimulantes ou sédatives se manifestent dès les premières heures. Le médicament est donc susceptible d'améliorer rapidement des symptômes non spécifiques de la dépression : anxiété, insomnie ou inhibition. Par contre, les symptômes plus spécifiquement dépressifs, tristesse, pessimisme, ne commencent à rétrocéder qu'après trois à cinq semaines. L'amélioration initiale est un encouragement à poursuivre le traitement. Un déprimé abattu, prostré, recevant un antidépresseur sédatif peut ressentir les effets initiaux du traitement

comme une aggravation, l'incitant au renoncement thérapeutique prématuré : « tu es encore plus mal sous médicament » n'est pas une formulation exceptionnelle.

Tableau 4. — Classification thérapeutique des antidépresseurs

Pôle psychotonique

Antidépresseurs psychotoniques
ou
désinhibiteurs
ou
stimulants

IMAO
Survector*
Kinupril*, Vivalan*
Timaxel*
Pertofran*
Clédial*

AD médians
ou
intermédiaires

Vagran*
Tinoran*
Tofranil*, Anafranil*
Stablon*
Prozac*
Floxyfral*

AD sédatifs
ou
anxiolytiques

Défanyl*
Prothiaden*
Pragmarel*
Insidon*, Athymil*
Sinéquan*
Laroxyl*
Ludiomil*
Surmontil*

Pôle sédatif

D) *Indications des antidépresseurs.* — Ils sont indiqués dans toutes les dépressions. Tricycliques et antidépresseurs de nouvelle génération ont en moyenne le même pourcentage de succès thérapeutique, entre 60 et 70 % des cas traités. L'efficacité des IMAO est légèrement inférieure vers 50 à 60 %. Mais chaque déprimé peut être

sensible à certaines molécules et résister à d'autres, justifiant la multiplicité des composés.

La gravité apparente de la dépression et son appartenance, névrotique ou psychotique, n'ont pas d'incidence sur la posologie. Toute dépression nécessite une dose efficace d'antidépresseurs, assez bien déterminée pour les molécules commercialisées. Les syndromes dépressifs de l'enfant justifient le recours aux antidépresseurs ; la dose se réfère au poids.

E) *Conduite d'un traitement antidépresseur.* — Un traitement antidépresseur est sans danger sous réserve de respecter les contre-indications à la prescription, assez rares, et d'assurer une surveillance régulière pour éviter les surdosages posologiques :

— la posologie initiale s'établit en fonction de l'âge et du poids. Une posologie optimale pour l'adulte est indiquée pour chaque antidépresseur. Il est de règle de commencer à une dose d'environ la moitié et d'augmenter progressivement pour atteindre en deux à trois semaines la posologie en principe requise. La survenue d'effets latéraux (tremblements, difficultés d'élocution, somnolence...) impose une baisse de la posologie. A l'inverse, une inefficacité incite à l'augmentation. En effet, la posologie optimale indiquée n'est qu'approximative car le métabolisme d'un antidépresseur dans l'organisme est très différent selon les sujets : certains le détruisent rapidement et d'autres lentement. L'activité des enzymes de destruction des antidépresseurs dans l'organisme semble déterminée génétiquement mais des facteurs externes peuvent l'influencer : ainsi la nicotine absorbée par les fumeurs stimule les enzymes du catabolisme.

La posologie doit être réduite chez le sujet après 65 ans en raison de la diminution des capacités enzymatiques ;

- il est indispensable de prescrire les sédatifs le soir car ils favorisent le sommeil et les stimulants le matin pour aider à l'activité ;
- les voies IM et IV sont réservées à l'hôpital. Par voie orale, les taux sanguins dépendent des phénomènes d'absorption digestive, variables selon les sujets ;
- la durée du traitement initial est au minimum de trois semaines avant de conclure à une inefficacité et d'envisager un changement de traitement : autre antidépresseur ou ECT ;
- tous les psychotropes peuvent être associés aux antidépresseurs pour parfaire leur action. Un traitement tranquilisant peut diminuer l'anxiété et les propensions suicidaires. La fréquente association antidépresseur-anxiolytique explique la confusion entre les deux types de produits. L'erreur dans la dépression est la prescription unique de tranquilisant qui peut provoquer une amélioration partielle mais ne guérit pas la maladie, en camoufle certains aspects et la pérennise.

Les antidépresseurs peuvent être associés entre eux à une exception formelle, l'association aux IMAO. Un délai est même requis lorsqu'on passe d'un IMAO à un autre type d'antidépresseur et inversement. L'association de deux antidépresseurs n'augmente pas l'efficacité. On peut, pour le confort, associer un stimulant le matin et un sédatif le soir.

F) *Durée*. — Un traitement d'entretien est indispensable après la guérison, d'une durée minimale de quatre à six mois (plus courte, le risque de rechute augmente). Après six mois de guérison, il ne se justifie plus, hormis pour la prévention des récurrences.

G) *Arrêt d'un traitement antidépresseur*. — La guérison acquise, le traitement peut être arrêté brusque-

ment. Les antidépresseurs, à l'inverse des tranquillisants, n'entraînent pas de phénomène de dépendance psychique ou physique. En réalité, l'arrêt progressif sur quelques semaines permet de détecter éventuellement des indices de rechute, imposant la reprise immédiate d'une posologie efficace.

4. La prise en charge psychothérapique de l'accès dépressif. — Au cours de l'accès dépressif, il ne saurait être entrepris de psychothérapie, au sens psychanalytique. Le déprimé, avec sa perte de motivation, son inertie à entreprendre, est dans l'incapacité d'effectuer la demande et de s'impliquer, condition indispensable à la démarche psychothérapique.

Le comportement psychothérapique s'organise autour des notions de bienveillance, d'écoute, de réassurance et de protection. Il convient d'expliquer au sujet ses tendances à la péjoration et d'étayer les propos sur des faits concrets.

La valorisation des qualités du sujet lui renvoie une image moins déplorable de lui-même et, dans une certaine mesure, restaure un narcissisme défaillant.

5. Thérapies comportementales et cognitives des dépressions. — Ces thérapies, relativement récentes, concernent essentiellement les dépressions névrotiques. Les mélancolies, surtout graves, ne relèvent pas de cette thérapeutique.

La comparaison entre les thérapies cognitives et les tricycliques montre une égalité d'action et parfois une supériorité des premières : le taux de rechute serait moindre, même par rapport aux sujets traités par lithium. Mais il s'agit de malades et d'indications différents.

A) *Les thérapies comportementales* dérivent de l'hypothèse comportementale des dépressions ; celles-ci ré-

sultent « d'une raréfaction des renforcements accessibles que reçoit le sujet dont notamment les renforcements sociaux positifs ». La thérapeutique vise à modifier le comportement du sujet :

- en l'aidant à retrouver un répertoire adéquat de renforcements positifs ;
- en l'entraînant à développer des comportements adaptés, incompatibles avec le statut de déprimé ;
- en l'engageant dans des activités plaisantes et satisfaisantes.

En somme, amener le sujet à « améliorer sa compétence sociale et son affirmation de soi ».

La thérapie comporte de véritables programmes d'entraînement à l'affirmation de soi, particulièrement directifs.

D'autres techniques comportementales peuvent compléter ce dispositif comme les plans d'activités où les activités quotidiennes sont enregistrées, la relaxation, l'amélioration de l'autocontrôle et de l'efficacité personnelle, les techniques de distraction ou la modification du comportement verbal consistant en la restriction des propos dépressifs.

B) *Les thérapies cognitives*. — Elles prennent en compte les symptômes cognitifs de la dépression, la « façon de penser » particulière des sujets (triade cognitive négative de Beck).

Le premier temps analyse cette façon de penser du déprimé mettant en évidence les anomalies du traitement de l'information ou « distorsions cognitives », responsables de la production excessive de pensées négatives et d'interprétations pessimistes de l'expérience vécue. Comme en thérapie comportementale, les séances de thérapie cognitive sont structurées, codifiées et directives. Le traitement comporte quatre étapes :

- d'abord une explication claire et didactique, fournie au déprimé, sur les liens qui unissent les cognitions, les sentiments (affects) et le comportement ;
- ensuite, le patient doit apprendre à mettre en évidence ses pensées négatives surgissant dans la vie quotidienne et à les relever par écrit ;
- ce stade d'auto-observation est suivi d'un apprentissage pour modifier les cognitions vers des pensées plus réalistes dites « alternatives » et en évaluer les effets dans la vie quotidienne ;
- enfin, le thérapeute prescrit à la fin de chaque séance des « tâches à domicile » précises pour consolider l'apprentissage des nouvelles cognitions.

Cette technique comporte en moyenne 10 à 20 séances sur une période de trois à six mois. Les résultats sont appréciés par une évaluation des changements cognitifs et de leur répercussion dans la vie sociale, à partir d'une ligne de base définie au début. Les modifications cognitives peuvent être mesurées à l'aide de différentes échelles (inventaire de dépression de Beck, échelle de désespoir, liste des pensées automatiques...).

L'indication principale des thérapies cognitives sont les dépressions névrotiques ou selon le DSM 3, les dysthymies ou « névroses dépressives » et les dépressions moyennes non mélancoliques. Un risque suicidaire ou un bas niveau d'autocontrôle contre-indique la méthode.

Les antidépresseurs peuvent être associés aux thérapies cognitives et comportementales.

6. La cure de sommeil peut amortir un stress important et permettre au sujet de s'adapter progressivement, avec une conscience obscurcie et une sensibilité apaisée, à un récent bouleversement de sa vie. Elle peut donc s'envisager dans les dépressions réactionnelles, pendant quelques jours.

II. — Traitements préventifs des rechutes

Toute dépression peut récidiver, surtout dans la psychose maniaco-dépressive, bipolaire ou unipolaire.

La rechute est fréquente dans les dépressions névrotiques. La prévention passe par des mesures psychothérapiques et existentielles alors que la chimiothérapie s'impose dans la PMD.

1. Les psychothérapies. — La dépression est parfois mal tolérée ou incomprise. Dante envoie au fond des enfers « ceux qui eurent le cœur triste dans la douceur de l'air ».

La famille, l'entourage, vainement insistants, en appellent à la volonté engloutie par la maladie. Cette mise en cause culpabilise le déprimé. Il faut au contraire le rassurer et justifier son incapacité à agir comme une inexorable et passagère conséquence de son état.

Le médecin devra confirmer cette réalité pathologique, convaincre de la nécessité et de l'efficacité d'un traitement, même d'une hospitalisation s'il redoute des idées de suicide dont l'aveu éventuel peut avoir une vertu cathartique, car le malade a le sentiment d'être incompris et de vivre une situation unique, indicible, incompréhensible pour l'autre. La nature du trouble de la personnalité, le niveau intellectuel, la capacité d'élaboration symbolique, de verbalisation, l'aptitude à l'introspection conditionnent le type de psychothérapie. L'expérience a montré que la psychothérapie d'inspiration analytique, parfois entreprise dans des dépressions mélancoliques d'aspect mineur, était un redoutable risque avec pour dénouement le suicide.

La psychanalyse, dont on a dit, abusivement caricaturée, « une maladie qui se prend pour son remède » (Karl Krauss cité par J.-M. Domenach), est mal adaptée par sa technique des associations d'idées spontanées ou induites. Elle se heurte au blocage pour l'ex-

pression des contenus de conscience ou au contraire à la profusion de fantasmes délirants. Parfois indiquée à distance de l'accès dépressif, mais avec quelle réserve ! Elle peut être ressentie comme une inquisition ; elle risque aussi, dans l'exploration des « lointains intérieurs », de réveiller des souvenirs, des affects et de soulever la houle dans un récent univers de culpabilité.

La psychothérapie d'inspiration analytique s'adresse aux dépressions névrotico-réactionnelles pour remonter à la situation conflictuelle déclenchante et faire prendre conscience des éléments potentialisateurs venus de l'enfance et conservés dans la mémoire affective, car les psychanalystes ont souvent raison d'affirmer qu'il n'y a pas de névroses (dépressions névrotiques) actuelles.

La psychothérapie de soutien et directive s'adapte aux besoins du sujet souvent engagé dans une trajectoire de désespoir ou de démission. C'est « la dialectique sentimentale » de Dubois, « la direction morale » de Janet.

Le malade expose les aléas survenus ; le thérapeute analyse les éléments réels ou symboliques dans un climat de bienveillance, d'intimité surtout, loin de la solennité jupitérienne de la visite médicale ou de la présence d'un époux ou d'un parent. Il pourra intervenir dans les problèmes existentiels : contentieux affectif, difficultés matérielles ou professionnelles.

2. Aménagements existentiels. — L'investigation des circonstances de la dépression met souvent en évidence des facteurs prédisposants ou déclenchants de la rupture dépressive. Les difficultés matérielles, les contentieux affectifs, les conditions professionnelles doivent être soigneusement investigués.

Les dépressions des sujets âgés isolés, éprouvant des difficultés à assumer les contraintes quotidiennes et souffrant de solitude, peuvent indiquer un placement salvateur en maison de retraite.

Les ennuis pécuniaires ont parfois de douloureuses

répercussions. Certains sujets résignés ignorent les possibles recours. L'aide des services sociaux doit être sollicitée pour les déprimés indigents.

Ailleurs, les conflits familiaux semblent particulièrement nocifs. Il faut examiner les modifications possibles des comportements des protagonistes. Il est parfois utile de rendre autonome un jeune adulte encore dépendant des parents, ou de conseiller des activités professionnelles à une femme dont la vie domestique casanière paraît terne, ennuyeuse, morose.

Toute dépression doit donner lieu à l'analyse du contexte de survenue. L'objectif est d'endiguer ou d'éviter les facteurs vitaux qui semblent avoir provoqué ou favorisé la rupture pathologique. Des éléments négatifs sont relevés, avec une égale fréquence, dans les dépressions endogènes : ce constat est un argument pour les défenseurs de la conception unitaire des dépressions.

3. Les médicaments préventifs des rechutes. — Ils sont de deux types. Les régulateurs de l'humeur et les antidépresseurs prescrits au long cours. Ils peuvent être associés.

A) Les régulateurs de l'humeur.

a) Le lithium est le chef de file. Cette substance naturelle est un ion comme le sodium (sel); elle fut introduite en médecine vers 1850 pour le traitement de la goutte et des troubles mentaux dépressifs (Trousseau). En 1897, Carl Lange rapporte l'efficacité du lithium dans la dépression.

Cade, un Australien, en établit en 1949 les propriétés antimaniaques. On l'utilise alors pour son activité sédatrice dans les états d'excitation. Mais de nombreux accidents toxiques signalés (certains mortels), la découverte du Largactil* en expliquent l'abandon.

Le travail méticuleux d'un Danois, Mogens Schou, confirme la double propriété du lithium : sédatrice et préventive. Il en précise les modalités d'emploi : la quantité

dans le sang (lithiémie) doit dépasser une certaine limite (0,6 millimole par litre) pour obtenir les effets thérapeutiques, mais rester inférieure à une marge au-delà de laquelle apparaissent les inconvénients (1 à 1,2 millimoles/litre). Cette zone d'efficacité de la lithiémie sans toxicité est appelée la « fourchette thérapeutique ».

Le lithium peut être prescrit au long cours, en traitement dit d'entretien, pendant des années, parfois toute la vie, pour prévenir les rechutes de la psychose mania-co-dépressive. Il est donné sous forme d'un sel, le carbonate (Théralite*) ou le gluconate (Neurolithium*), mais d'autres sels peuvent être employés (sulfate, citrate, etc.) par voie orale en une ou deux prises quotidiennes. La posologie est progressivement augmentée pour obtenir la lithiémie utile. Initialement, il faut pratiquer une prise de sang par semaine pour obtenir les chiffres de lithiémie dans la « fourchette thérapeutique ». Ensuite, le contrôle sanguin a lieu tous les mois, ou tous les deux mois. Il existe peu de contre-indications au traitement : l'insuffisance rénale car le lithium est éliminé par le rein et le régime sans sel. Dans ce cas, le lithium prendrait la place du sodium dans la cellule provoquant des troubles graves. Les sujets doivent être informés de la nécessité de saler normalement les aliments.

Le lithium, souvent indiqué pour prévenir les rechutes dans les formes bipolaires de la psychose mania-co-dépressive, est efficace dans les deux tiers des cas traités : une disparition totale des récurrences s'observe dans un tiers des cas, et une atténuation de la fréquence, de la sévérité et de la durée des accès dans l'autre tiers.

Dans les formes unipolaires dépressives, le choix s'effectue entre le lithium ou un antidépresseur en continu. Les deux méthodes sont globalement équivalentes ; leur association ne semble pas plus efficace qu'un seul traitement. Certains sujets répondent mieux à l'un ou à l'autre.

Le lithium peut être arrêté sans problème. Il n'y a pas de dépendance au lithium. Cependant, après la cessa-

tion, la maladie reprend le cours évolutif antérieur quelle que soit la qualité du résultat. En ce sens, le traitement est purement suspensif et non curatif. Quelquefois, après des années, l'abstention thérapeutique n'est pas suivie de rechutes ; mais ces observations sont rares.

b) *La carbamazépine* (Tégréto^{*}), prescrite dans l'épilepsie, est un autre régulateur de l'humeur. Il donne dans la prévention des rechutes les mêmes résultats que le lithium. Les formes à cycles rapides (plus de quatre accès par an) en seraient l'indication privilégiée. Les formes résistant à un produit peuvent répondre à l'autre.

L'association des deux médicaments peut réussir quand un seul a échoué.

Le principe de la conduite du traitement est identique à celui du lithium. Il faut obtenir un taux sanguin de Tégréto^{*} compris entre 6 et 12 mg par litre. La carbamazépine est très bien tolérée mais son efficacité est aussi exclusivement suspensive.

c) D'autres molécules semblent capables de prévenir les rechutes :

- le valpromide (Dépamido^{*}) ;
- le valproate (Dépakine^{*}),

mais la preuve n'en est pas formellement établie.

B) *Les antidépresseurs au long cours.* — Le maintien du traitement antidépresseur après l'accès a pour objet la prévention des rechutes. Les molécules doivent être utilisées à la même posologie que celle requise pour la guérison de la dépression. Une surveillance médicale s'impose en référence à certains effets indésirables éventuels. Les formes bipolaires ne relèvent pas d'une prévention par les antidépresseurs car ils déterminent des virages maniaques dans la moitié des cas. Cette prévention s'envisage pour les formes unipolaires des dépressions endogènes et pour les dépressions récidivantes névrotiques. Dans ces dernières, le lithium ne semble pas opérant.

4. Les formes résistantes. — Certaines dépressions résistent au traitement et évoluent sur un mode chronique. Il convient d'en rechercher les causes. Elles sont schématiquement de trois types :

- cause organique : détérioration débutante chez un sujet après 50 ans, affections somatiques non reconnues. Selon Akiskal, 10 % de déprimés résistants auraient un cancer profond, qu'il convient de rechercher systématiquement ;
- conditions affectives ou existentielles néfastes ;
- troubles de personnalité associés ; ils peuvent nécessiter des orientations thérapeutiques à côté ou en dehors des antidépresseurs.

5. Voyages. Climats. — Une tradition obsolète, pour « changer les idées » et en dépouiller la tristesse, conseillait les voyages aux déprimés.

Mais les décors ne modifient pas leurs états d'âme ; il n'est pas de voyageurs sans bagages.

Seul Salvador Dali aurait trouvé au cap Creus le « refuge de la mélancolie planétaire ».

Les climats n'agissent guère plus. Cependant, le P^r Gayral de Toulouse avait statistiquement établi l'augmentation de suicides par vent d'autan.

Par contre, les dépressions névrotiques semblent tirer profit de la montagne à petite altitude. Le Jura, en particulier, avec ses lacs paisibles et ses forêts, paraît avoir une action sédative, comme aussi certaines stations thermales spécialisées (Divonne, Néris-les-Bains, Saujon...).

La mer ! Surtout l'océan Atlantique, la Manche, par son action stimulante, ne convient pas au sujets « nerveux », enfants en particulier. Léon Daudet écrivait : « La mer tue les faibles, fait éclater les pléthoriques. » En somme, elle ne devrait être recommandée qu'aux bien-portants.

CONCLUSION

Connaître la dépression, la repérer dans ses divers avatars, la démystifier, c'est assurer sa guérison. « Il n'est si longue nuit qui n'atteigne l'aurore » (Shakespeare, *Macbeth*).

BIBLIOGRAPHIE

- Beck A. T., Rush A. J., Shaw B., Emery G., *Cognitive therapy of depression*, New York, Guilford Press éd., 1979.
- Bertschy G., Vandel S., Volmat R., Epidémiologie de la dépression : données récentes, *Psychiatrie et Psychologie*, 1988, 3, 3, 149-158.
- Blackburn I. M., Cottraux J., *Thérapie cognitive de la dépression*, Paris, Masson éd., 1987.
- Caillard V., Etude épidémiologique des troubles de l'humeur chez les Amish, *Actualités internationales en Psychiatrie*, 1985, 2, 19-23.
- Chabrol H., *La dépression de l'adolescent*, Paris, PUF éd., 1988.
- Debray Q. et Caillard V., Facteurs génétiques et facteurs d'environnement dans l'étiologie de la dépression, in *La maladie dépressive*, Rueil-Malmaison, Laboratoire Ciba Geigy éd., 1983.
- Deniker P., Lempérière T., Guyotat J., *Précis de psychiatrie clinique de l'adulte*, Paris, Masson éd., 1990.
- Domecq J.-B., *Leçons de philosophie*, t. 1, Paris, Marcel Caletier éd., 1916.
- Féline A., Hardy M. C., Le Goc I., Anxiété et/ou dépression, in *La maladie dépressive*, Rueil-Malmaison, Ciba Geigy éd., 1983, 145-168.
- Fouks L., Guibert S., Montot M., La notion du temps vécu chez P. Janet, *Ann. médicopsychol.*, 1988, 148, 10, 941-952.
- Freud S., Deuil et mélancolie (1915), in *Métapsychologie*, Paris, Gallimard éd., 1968, 145-185.
- Golse B., Messerschmitt P., *L'enfant déprimé*, Paris, PUF éd. (coll. « Nodules »), 1983.
- Guelfi J. D., Boyer P., Consoli S., Olivier-Martin R., *Psychiatrie*, Paris, PUF éd., 1987.
- Hardy P., Féline A., de Bonis M., Rigaud A. S., Epelbaum C., Dépressions avec attaques de panique : caractéristiques cliniques et prévalence en milieu hospitalier, *Can. J. Psychiatry*, 1990, 35, 64-70.
- Klein M., Contribution à l'étude de la psychogenèse des états maniaco-dépressifs (1934), in *Essais de psychanalyse*, Paris, Payot éd., 1987, 311-340.
- Koupernik C., Lôo H., Zarifian E., *Précis de Psychiatrie*, Chevilly-Larue, Flammarion Médecine-Sciences éd., 1982.
- Lévy B.-H., *Les derniers jours de Charles Baudelaire*, Paris, Grasset éd., 1988.
- Lôo H., Olié J.-P., Gay C., *Le déprimé et son lithium*, Paris, Masson éd., 1989.
- Matussek P., Neuner R., Loss events preceding endogenous and neurotic depressions, *Acta Psychiatr. Scand.*, 1981, 64, 340-350.
- Mendlewicz J., *Manuel de psychiatrie biologique*, Paris, New York, Barcelone, Milan, Mexico, São Paulo, Masson éd., 1987.

- Pichot P., Guelfi J. D., Pull C. B., Sémiologie de la dépression, *Encyclop. Méd. Chir.*, Paris, Psychiatrie, 37110 A 10, 12-1980.
- Rosenthal N. E., Sack D. A., Gillin J. C. *et al.*, Seasonal affective disorder : a description of the syndrome and preliminary findings with light therapy, *Arch. Gen. Psychiatry*, 1984, 41, 72-80.
- Rouillon F., *Dépression, la rechute est-elle inéluctable ?*, Puteaux, Laboratoire Hoechst éd., 1985.
- Spitz A., *De la naissance à la parole*, Paris, PUF éd., 1968.
- Zarifian E., Lôo H., *Les antidépresseurs. Aspects biologiques, cliniques et thérapeutiques*, Neuilly-sur-Seine, Roche éd., 1982, 476 p.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-Propos	3
Introduction	6
Chapitre Premier. — La dépression ! Qu'est-ce ? ou les définitions des dépressions	11
Chapitre II. — Comment s'exprime-t-elle ? ou la sémiologie des dépressions	30
Chapitre III. — Classifications et évaluation des dépressions	54
Chapitre IV. — Qui la dépression touche-t-elle ? ou données épidémiologiques	69
Chapitre V. — D'où vient-elle ? Hypothèses étiologiques des dépressions	77
Chapitre VI. — Comment guérir les dépressions ? ou les traitements	103
Conclusion	125
Bibliographie	126

Imprimé en France
Imprimerie des Presses Universitaires de France
73, avenue Ronsard, 41100 Vendôme
Janvier 1993 — N° 38 041

que sais-je?

COLLECTION ENCYCLOPÉDIQUE

fondée par Paul Angoulvent

Derniers titres parus

- | | | | |
|------|---|------|--|
| 2685 | Les médias du futur
F. VASSEUR | 2705 | La politique étrangère de la
V ^e République
P.-M. de LA GORCE
et A.-D. SCHOR |
| 2686 | La Légion étrangère
A.-P. COMOR | 2706 | L'orléanisme
H. ROBERT |
| 2687 | Le luxe
J. CASTARÈDE | 2707 | L'investissement dans l'intel-
ligence
C. AFRIAT |
| 2688 | Le pragmatisme
P. GAUCHOTTE | 2708 | Cromwell, la révolution d'An-
gleterre et la guerre civile
J.-P. POUSSOU |
| 2689 | Histoire locale et régionale
G. THUILLIER et J. TULARD | 2709 | Le procès administratif
P. FANACHI |
| 2690 | Les sources du droit du travail
B. MATHIEU | 2710 | La science et les sciences
G.-G. GRANGER |
| 2691 | Histoire de la sémiotique
A. HÉNAULT | 2711 | La philosophie de Pascal
J. BRUN |
| 2692 | Elites et élitisme
G. BUSINO | 2712 | Histoire de l'individualisme
A. LAURENT |
| 2693 | L'épilepsie
P. JALLON | 2713 | La nouvelle macroéconomie
classique
H. LAMOTTE et J.-P. VINCENT |
| 2694 | Les fondations
C. DEBBASCH et P. LANGERON | 2714 | Les bibliothèques universitaires
J.-P. CASSEYRE et C. GAILLARD |
| 2695 | Le développement libidinal
B. BRUSSET | 2715 | Les transmissions d'entreprises
Y. CHAPUT |
| 2696 | La gérontologie
C. de JAEGER | 2716 | Histoire de la Guerre sainte
J.-G. RUELLAND |
| 2697 | La libre circulation des personnes
dans la CEE
H. de LARY | 2717 | L'apprentissage de l'oral et de
l'écrit
A. GIROLAMI-BOULINIER |
| 2698 | Le boulangisme
J. GARRIGUES | | |
| 2699 | La gestion de patrimoine
B. PAYS | | |
| 2700 | Les toxicomanies de l'adolescent
H. CHABROL | | |
| 2701 | L'informatisation des villes
G. DUPUY | | |
| 2702 | La logique floue
B. BOUCHON-MEUNIER | | |
| 2703 | Le droit de la personnalité
B. BEIGNIER | | |
| 2704 | L'entreprise en réseau
G. PACHE et C. PARAPONARIS | | |



KR-446-524